

成長と発達コース

事故と救急

名古屋市立大学病院 救急科

今井一徳

本日の講義では、LINE オープンチャットを多用します。

準備をお願いします。

参加コード ped0323



LINE オープンチャット

<https://apllio.com/how-to-start-line-openchat>

- 個人同士で個別連絡は取れません
- IDもこのオープンチャット専用で独自に指定して大丈夫です
→個人のLINE ID が「ばれる」ことはありません
- 以下のQRコードを読み込んで、参加者名と参加コードを入力して下さい
- LINEの投稿そのものは評価対象にしません
 - LINE を使用していない
 - 参加したくないという方は、近くの人に見せてもらって下さい。
- その場合、出欠の問題がありますので、
講義終了後申告して下さい。



参加コード ped0323

■ LINE

□ 今の気分は？

- e.g. 「最高！」 「ワクワク」 「だるい」 「ねむい」

□ 今の気分を色で表すと？

- e.g. 「赤」 「緑」 「黄色」 「紫」

□ スタンプ？？

Grand rule

■ 出席について

- 小児科規定の出席用紙（コメントは "google formへ" で可）
- 終了時の振り返り（google formを予定）

■ テストについて

- 講義内ではすべての内容に触れられません
- 別途用意してある自己学習用の資料も出題範囲とします

■ chat への積極的な書き込みをお願いします

- 質問もどんどん書き込んで下さい
- chat での雑談も歓迎、自由に意見交換して下さい

■ chatの内容そのものは成績の評価対象としません

講義の目標 ①

■ 典型的な症例について

- 緊急性がある病態かどうか「評価」できる
- 呼吸窮迫・呼吸不全・ショックの病態であるかを判断できる

■ 小児の事故と事故予防について

- 事故が起こるメカニズムを説明できる
- 事故予防がなぜ重要であるかを説明できる
- 適切な「指導」を想起できる

■ 子ども虐待について

- 典型的な症例について「虐待」の可能性を指摘できる
- 社会問題としての側面を説明できる

講義の目標 ②

■ Advocacy について

- 小児医療におけるadvocacy の重要性を説明できる
- 臨床的な判断を行う際に 臨床倫理の 4 原則を想起できる
- 主治医として自分なりの意見を言える
- チームの中での自身の役割を述べられる

■ 災害と小児

- “災害” とは何か、を説明できる
- “災害” 時に、小児に起こりえることの例を挙げられる

session 1

救急診療における小児の特徴

■ LINE

□ 「小児救急」のイメージは？

[illegible]

小児救急と緊要な病例
の外で地元の特設救急が
確保する協力は、東京都大田区
の区議会と東京大東医療センタ
ー大田病院の両者は、年間1万
3000人以上の小児の救急患者が属
する救急科で、区内の小児科医
43人が、平日の午後5時から11時
までで対応が確保する。

夜の小児救急支え合う

[illegible]

2008年4月23日 每日新聞【埼玉版】

NO	FI	26	10
----	----	----	----

资料来源：根据《中国统计年鉴》整理。

26

ニエース
追跡



小児医療 崩壊の危機に直面

立ち上がる母親たち

[illegible]

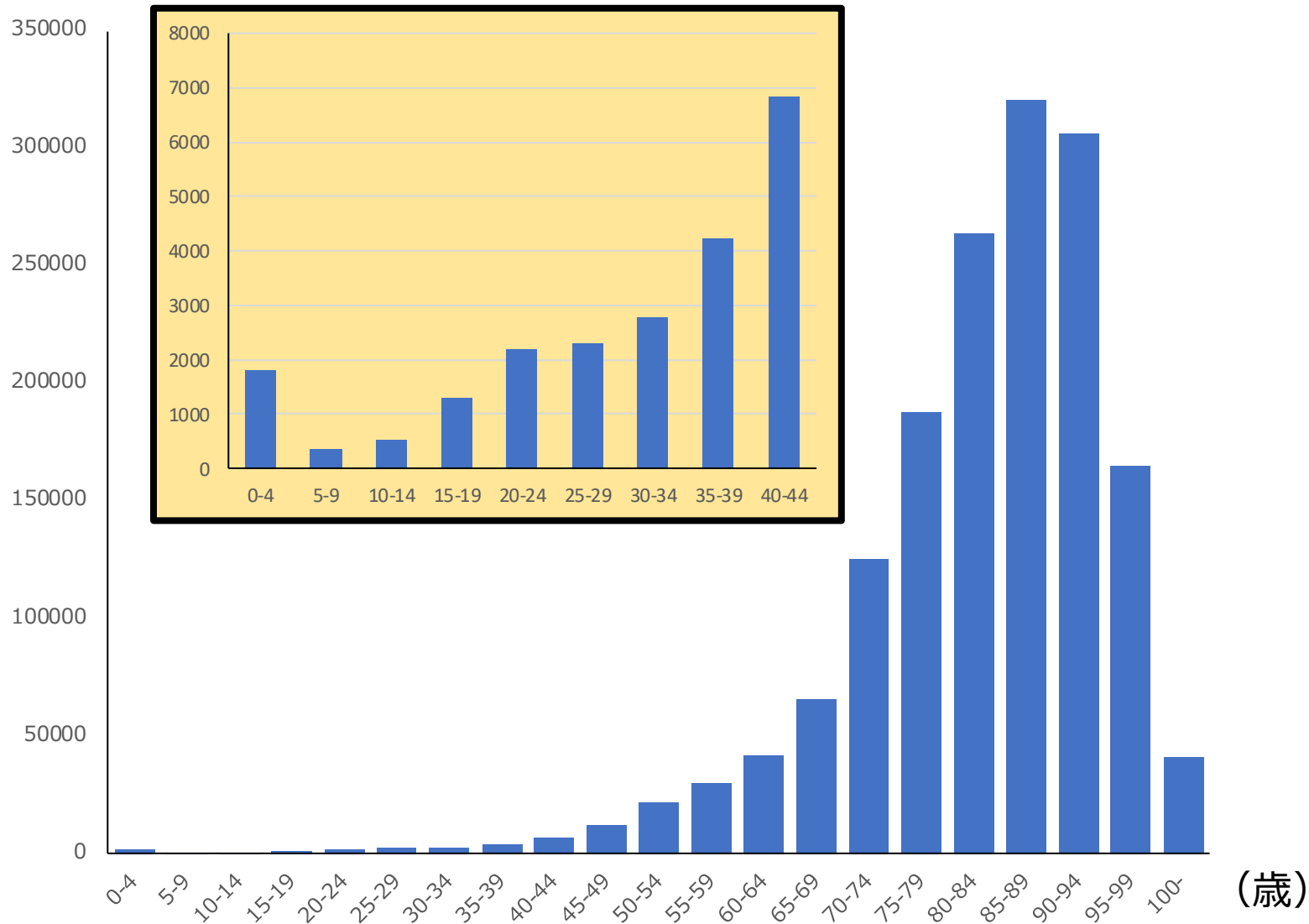
1. **Introduction** (10%)
2. **Background** (10%)
3. **Methods** (10%)
4. **Results** (10%)
5. **Discussion** (10%)
6. **Conclusion** (10%)
7. **References** (10%)
8. **Appendix** (10%)
9. **Tables** (10%)
10. **Figures** (10%)

[illegible]

軽症患者の殺到に医師疲弊

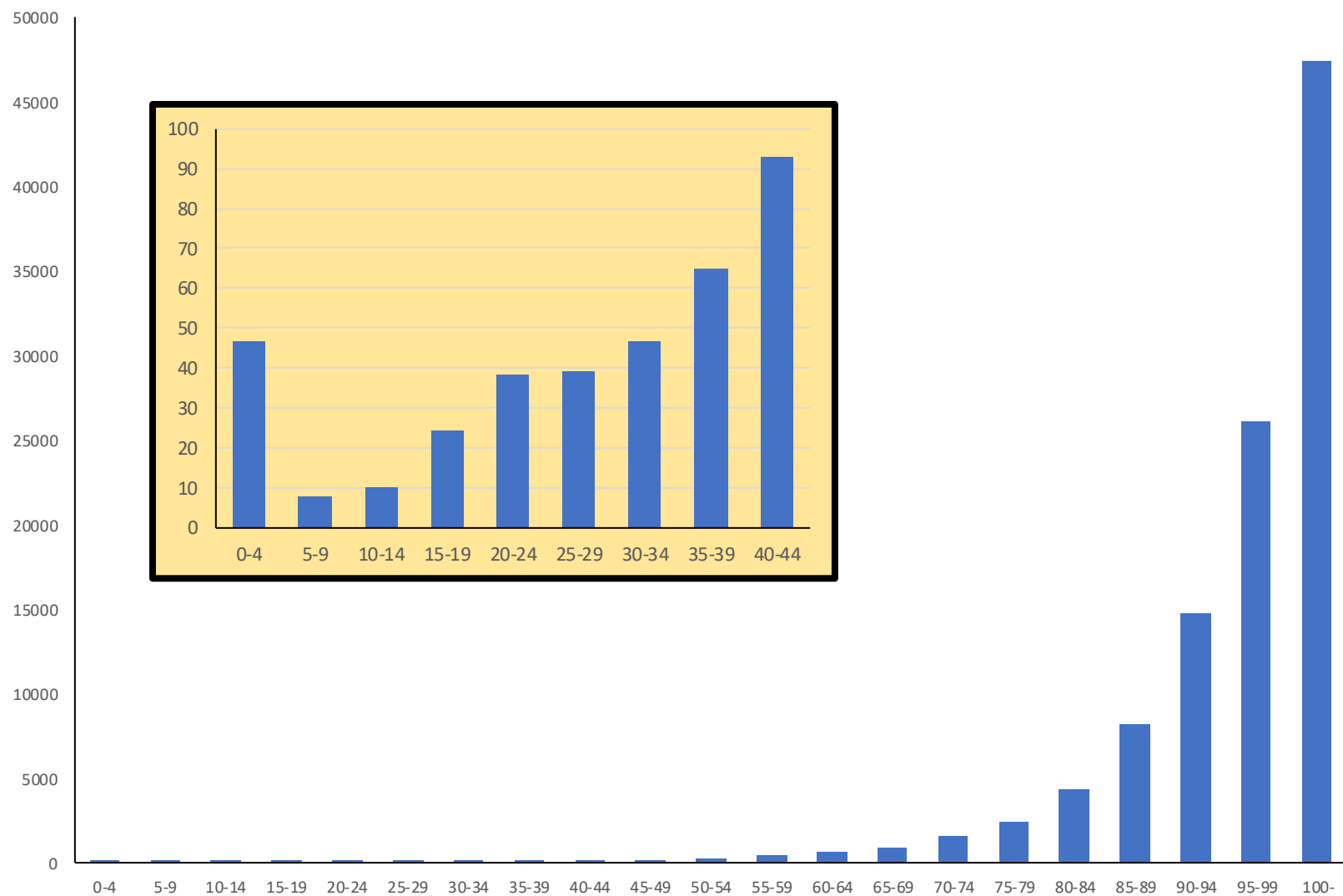
年齢階級別死亡数 (令和6年)

(人)



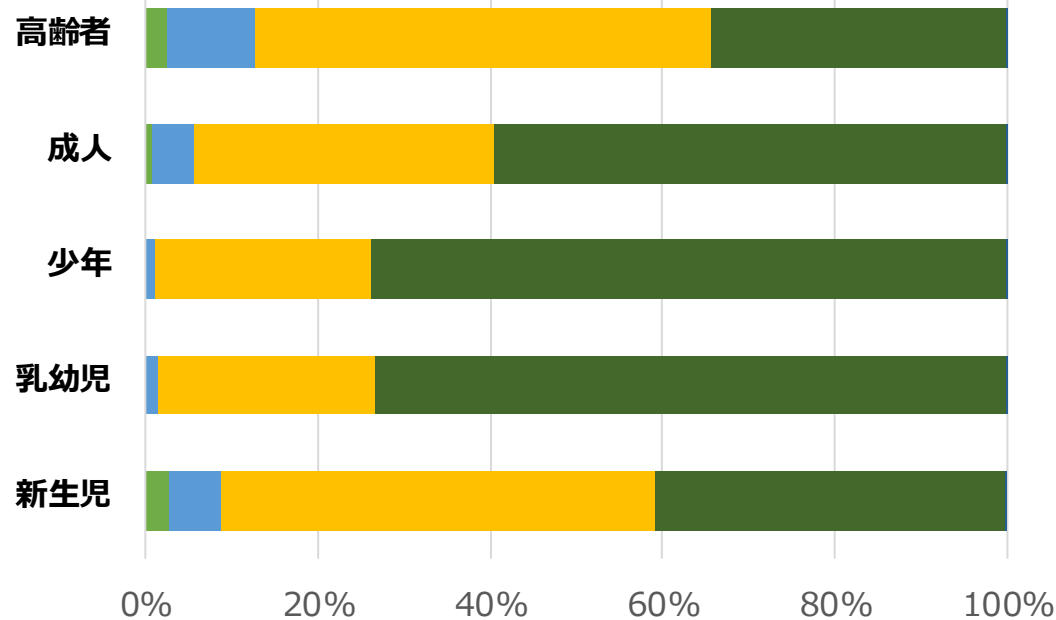
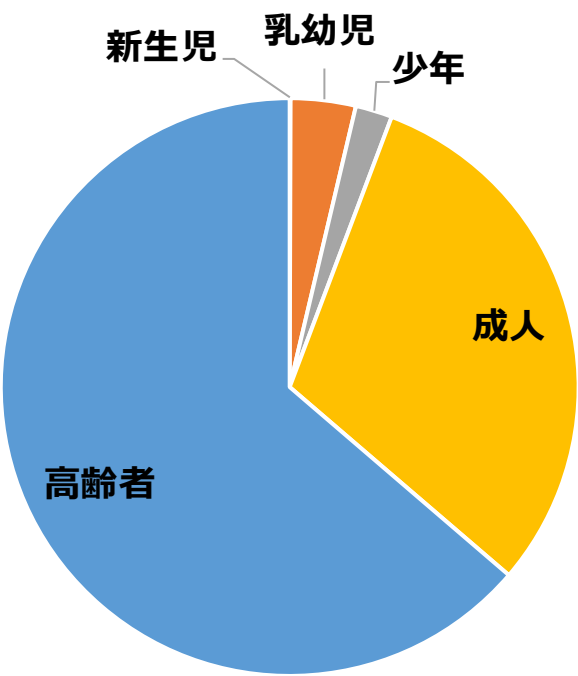
年齢階級別死亡数 (人口10万対 令和6年)

(人)



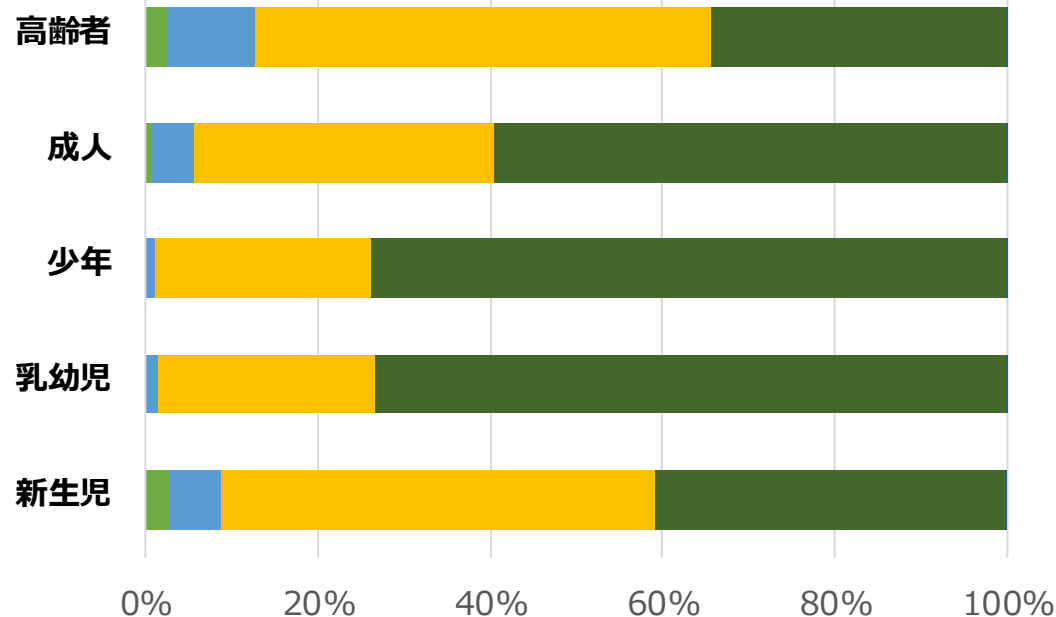
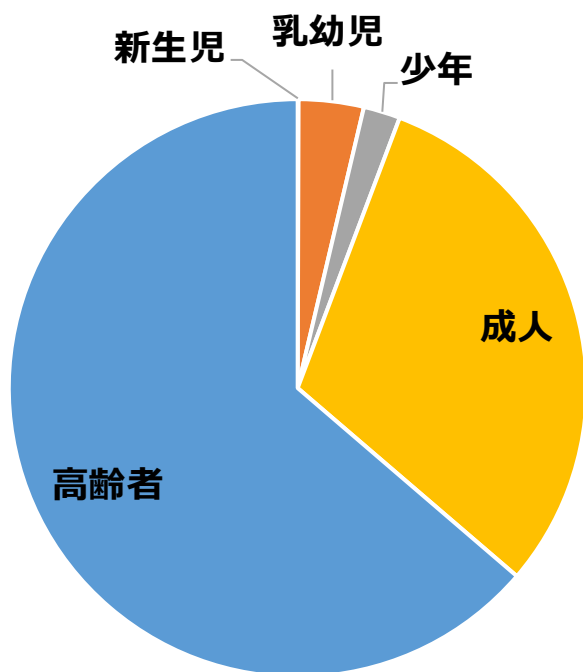
(歳)

重症度・年齢区分別 緊急自動車搬送数



	新生児	乳幼児	少年	成人	高齢者
死亡	49	205	61	7,753	59,304
重症	107	1,514	745	53,402	233,098
中等症	908	33,155	18,664	384,971	1,212,889
軽症	733	96,292	54,721	654,661	791,134
その他	5	9	6	290	503

重症度・年齢区分別 緊急自動車搬送数



	新生児	乳幼児	少年	成人	高齢者
死亡	49	205	61	7,753	59,304
重症	107	1,514	745	53,402	233,098
中等症	90	90	90	384,971	1,212,889
軽症	733	96,292	54,721	654,661	791,134
その他	5	9	6	290	503

死亡全体の 0.46%

小児“科”救急

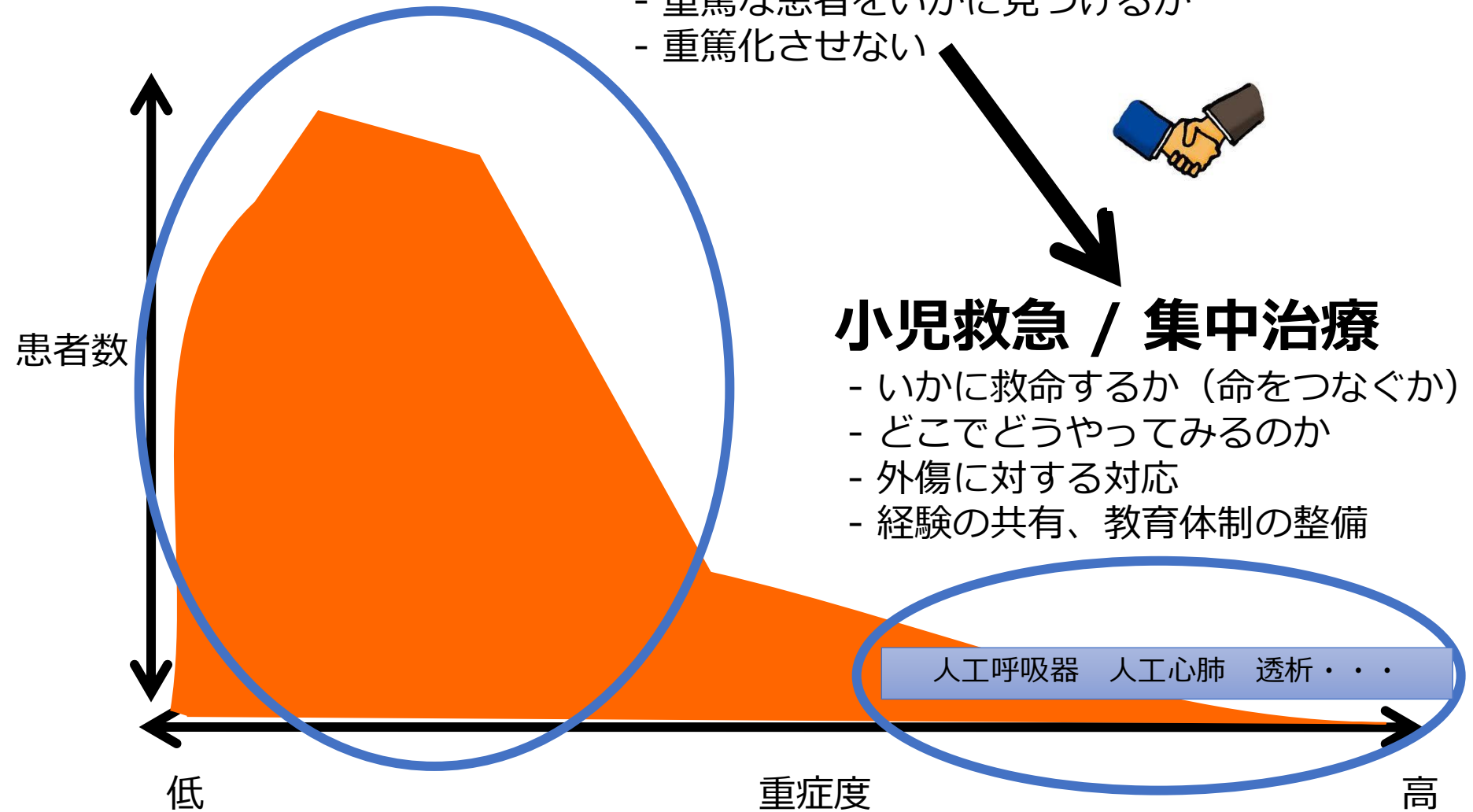
- 圧倒的な患者数
- 重篤な患者をいかに見つけるか
- 重篤化させない



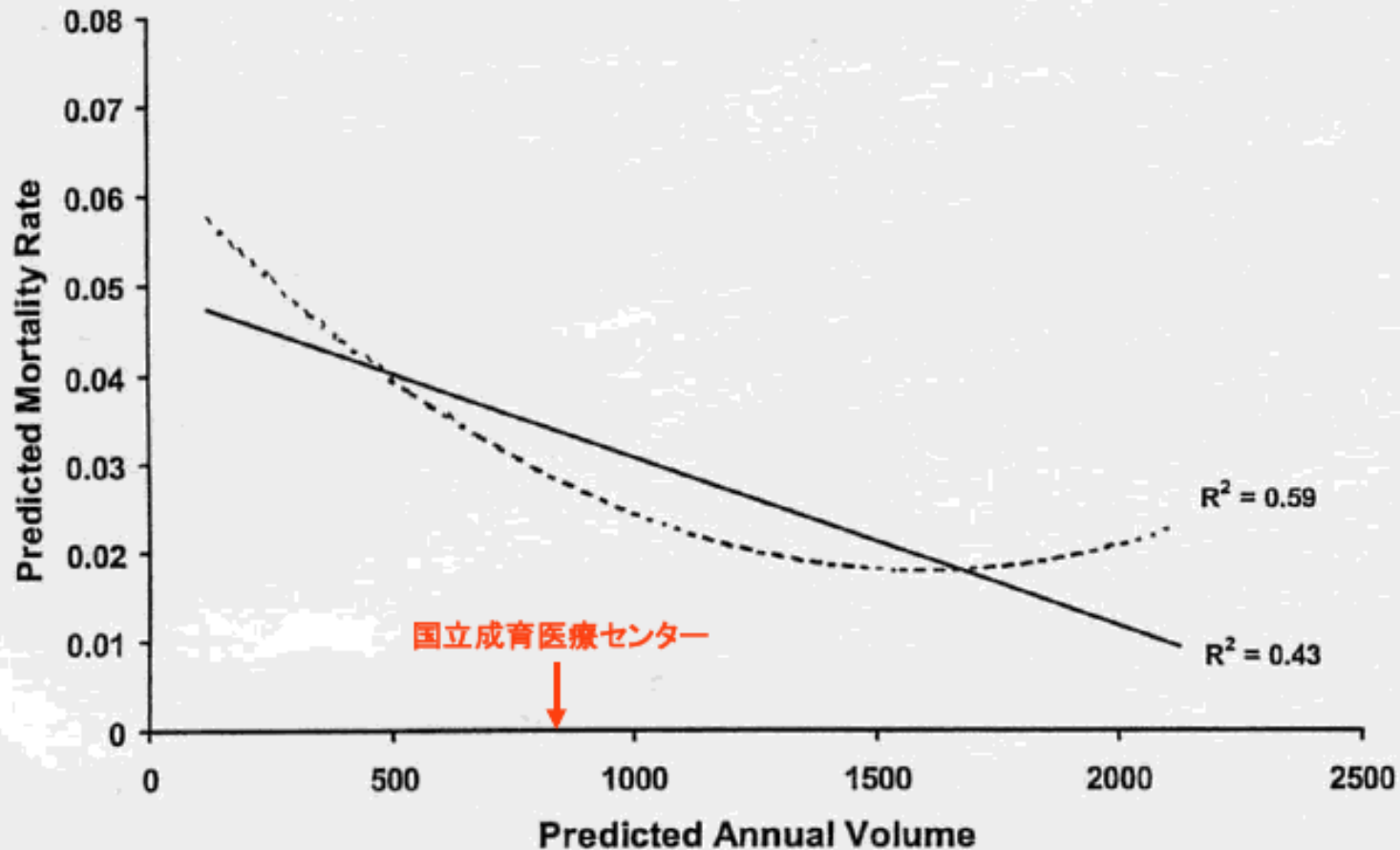
小児救急 / 集中治療

- いかに救命するか（命をつなぐか）
- どこでどうやってみるのか
- 外傷に対する対応
- 経験の共有、教育体制の整備

人工呼吸器 人工心肺 透析・・・



PICU年間入院患者数と死亡率



中～大規模の PICU での死亡率が最も低くなる

Take home message ①

■ 小児救急における課題

- 大量の軽症者の中から適切に重症を見つける
 - ・ ABCDE アプローチ
- 重症対応の経験値
 - ・ 集約化の必要性, 研修のあり方

session 2

小児の診察

■ LINE

- 小児を診察するときに
どんなことに気をつけたらいいですか？

video:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=487&v=xAmtU1-YOcI&feature=emb_logo

■ LINE に書き込んで下さい

- ER で担当しています
- 「まず何を考えますか？」
- 「まず何をしますか？」



▶ たたかう

ぼうぎょ

にげる

正体をあばく

犯人が現れた！！

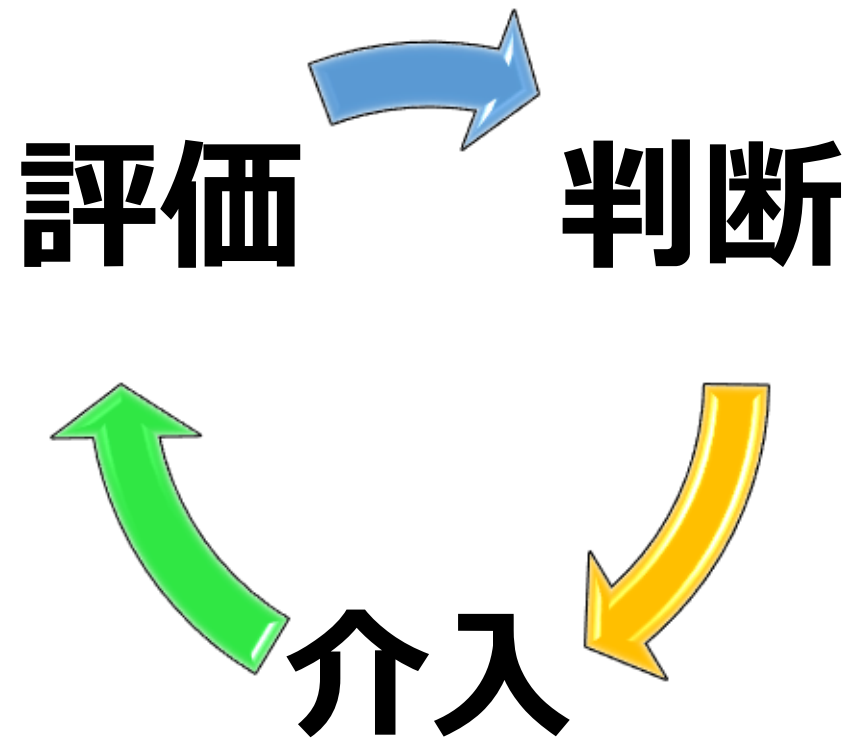
緊急度が高い

つまり、

死んじゃいそう

かどうかを

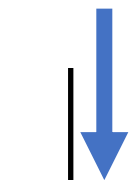
まず、評価する



この過程のどの段階であっても、生命を脅かす問題を認めたら直ちに救命処置を開始する。

換氣

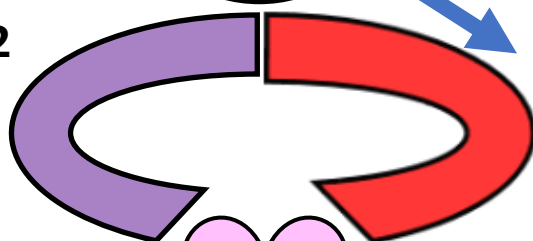
$P_B O_2$



$P_A O_2$

$\dot{V}/Q$ mismatch
shunt
擴散障害

$S_{\bar{v}} O_2$



$P_a O_2$

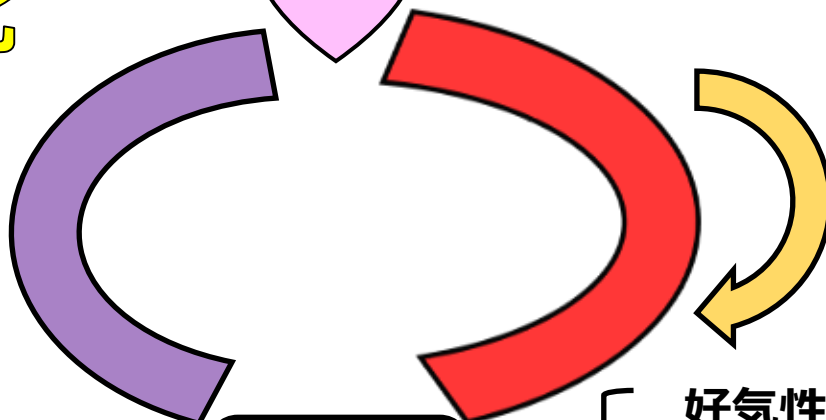
$S_a O_2$



$C_a O_2$

Hb

酸素化



CO

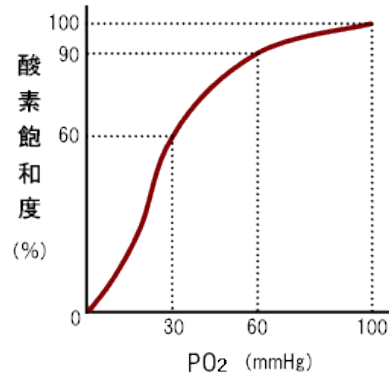
HR $\times$ SV

前負荷 後負荷 收縮力

DO_2

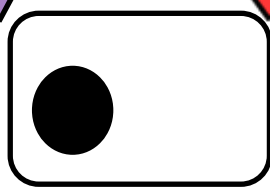
好氣性代謝: (2+36) ATP + H_2O + CO_2

嫌氣性代謝: (2+0) ATP + Lac^-



酸塩基平衡

$\dot{V}O_2$ $\dot{V}CO_2$



切迫した状況

呼吸性

循環性

突然的心臓性（不整脈）

呼吸窮迫

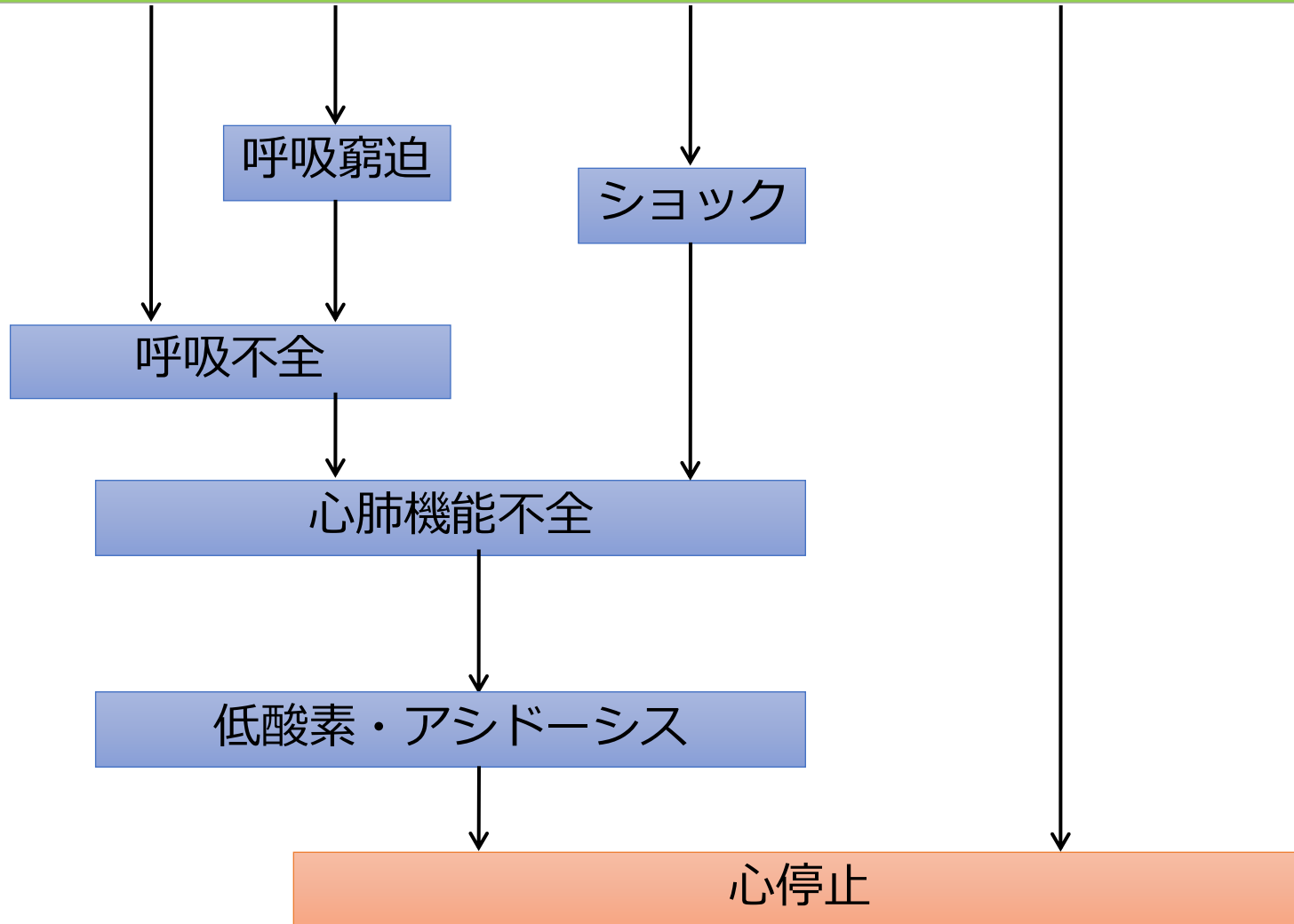
ショック

呼吸不全

心肺機能不全

低酸素・アシドーシス

心停止



正常

呼吸努力の増加

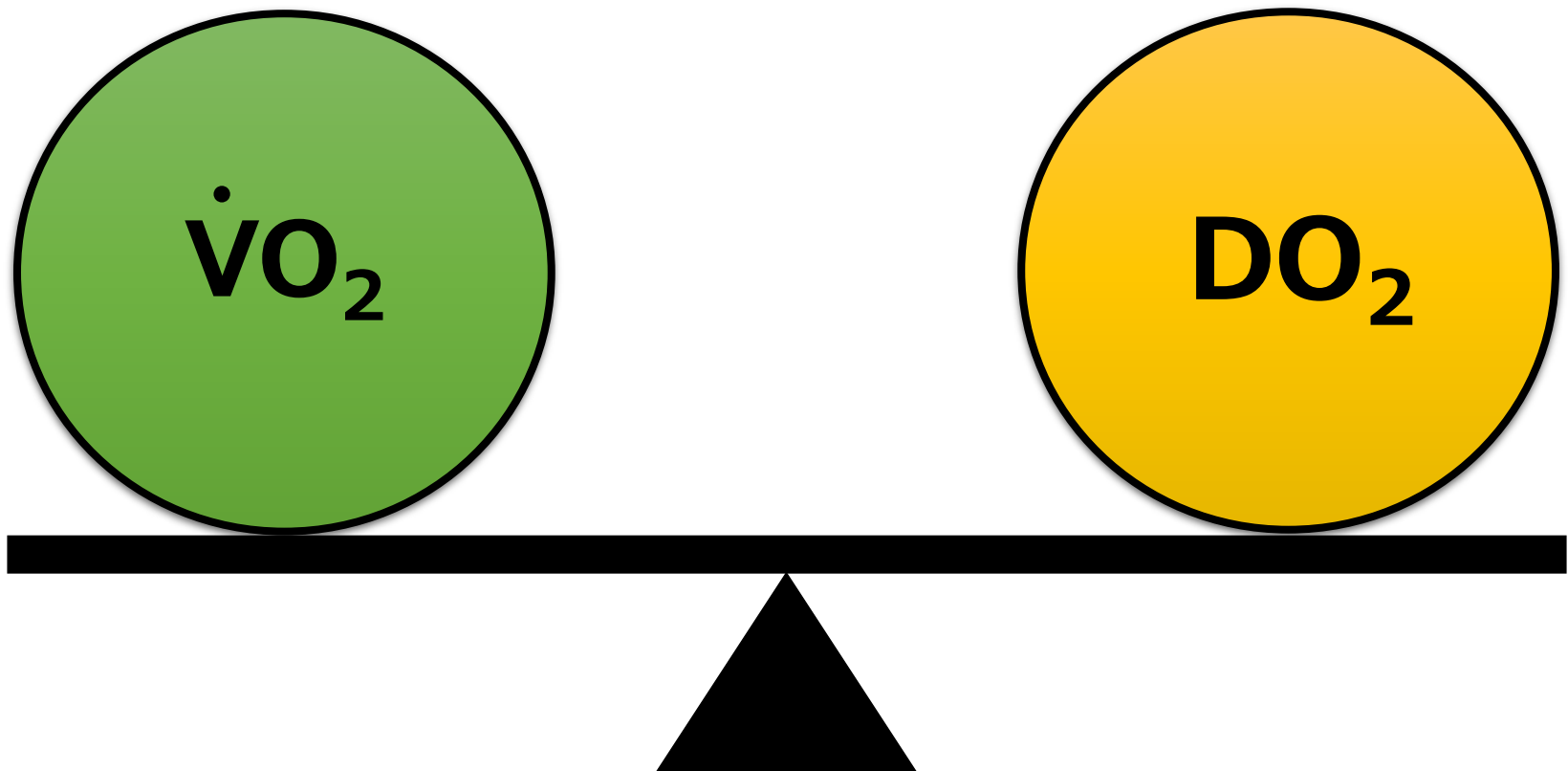


SpO₂

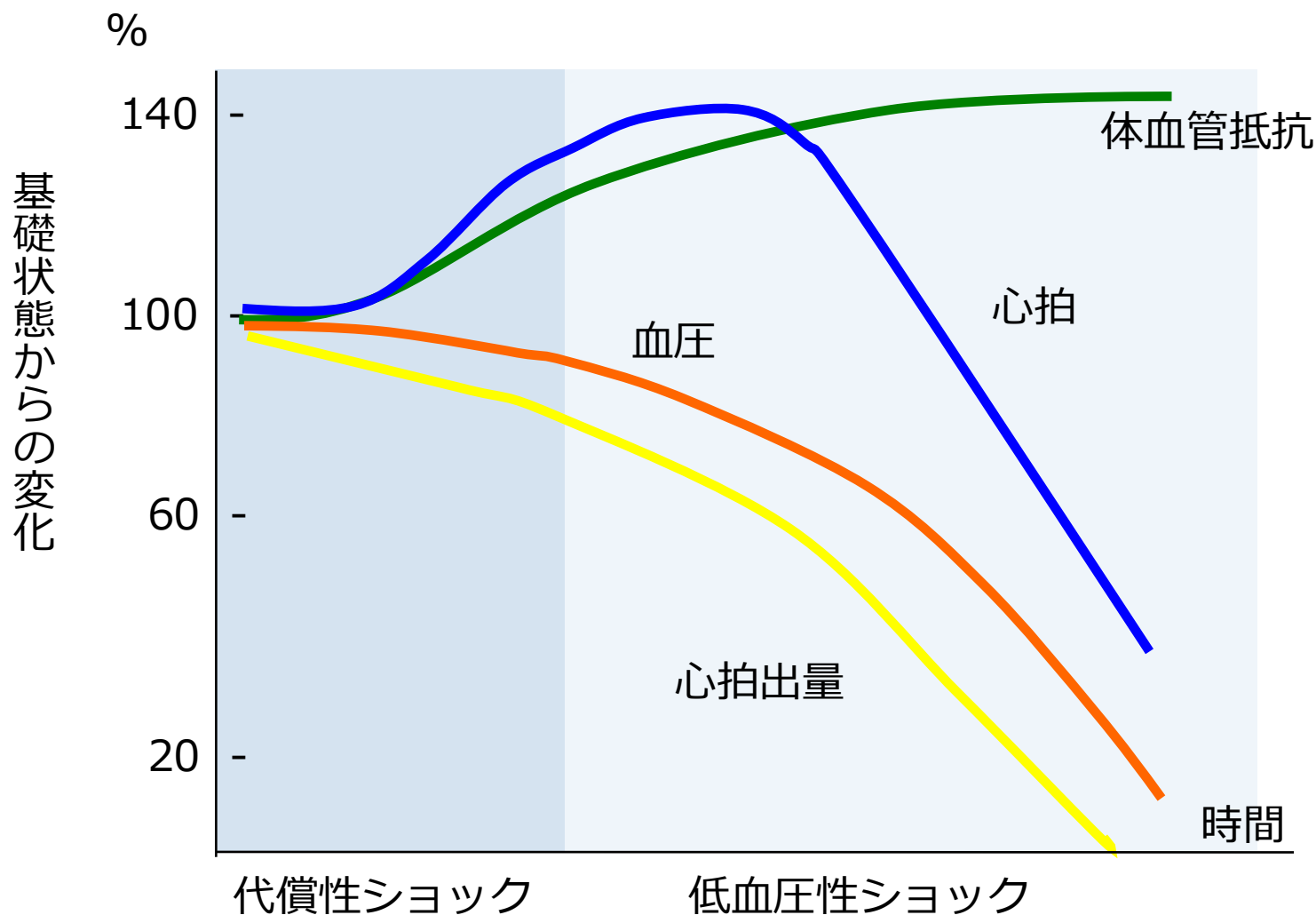
呼吸窮迫

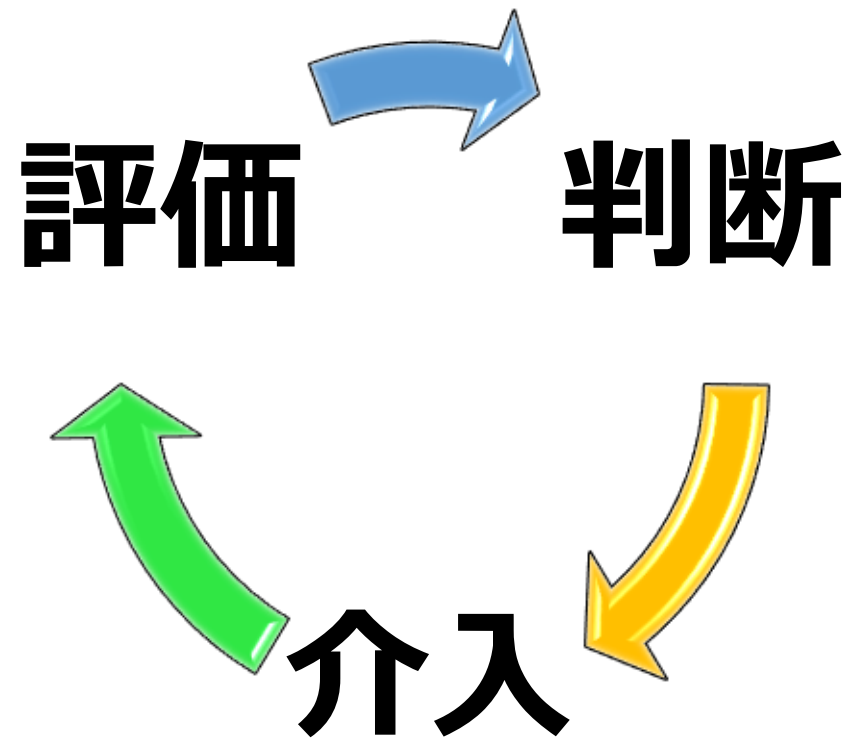
呼吸不全

ショックとは？



ショックの重症化に伴う血行動態の変化





この過程のどの段階であっても、生命を脅かす問題を認めたら直ちに救命処置を開始する。

外見（見かけ）

- ・筋緊張
- ・疎通性
- ・精神的安定
- ・視線
- ・言葉、泣き声

呼吸仕事量

- ・呼吸仕事量の増加
 - 鼻翼呼吸、陥没呼吸
- ・呼吸努力の減弱/消失
- ・異常な呼吸音
 - 喘鳴、呻吟

循環・皮膚色

- ・皮膚色の異常、出血



心肺停止？

反応がない
呼吸がない
異常な呼吸(死戦期呼吸)
判断に自信が持てない

YES



CPR

(cardiopulmonary resuscitation)

NO



**ABCDE
アプローチ**

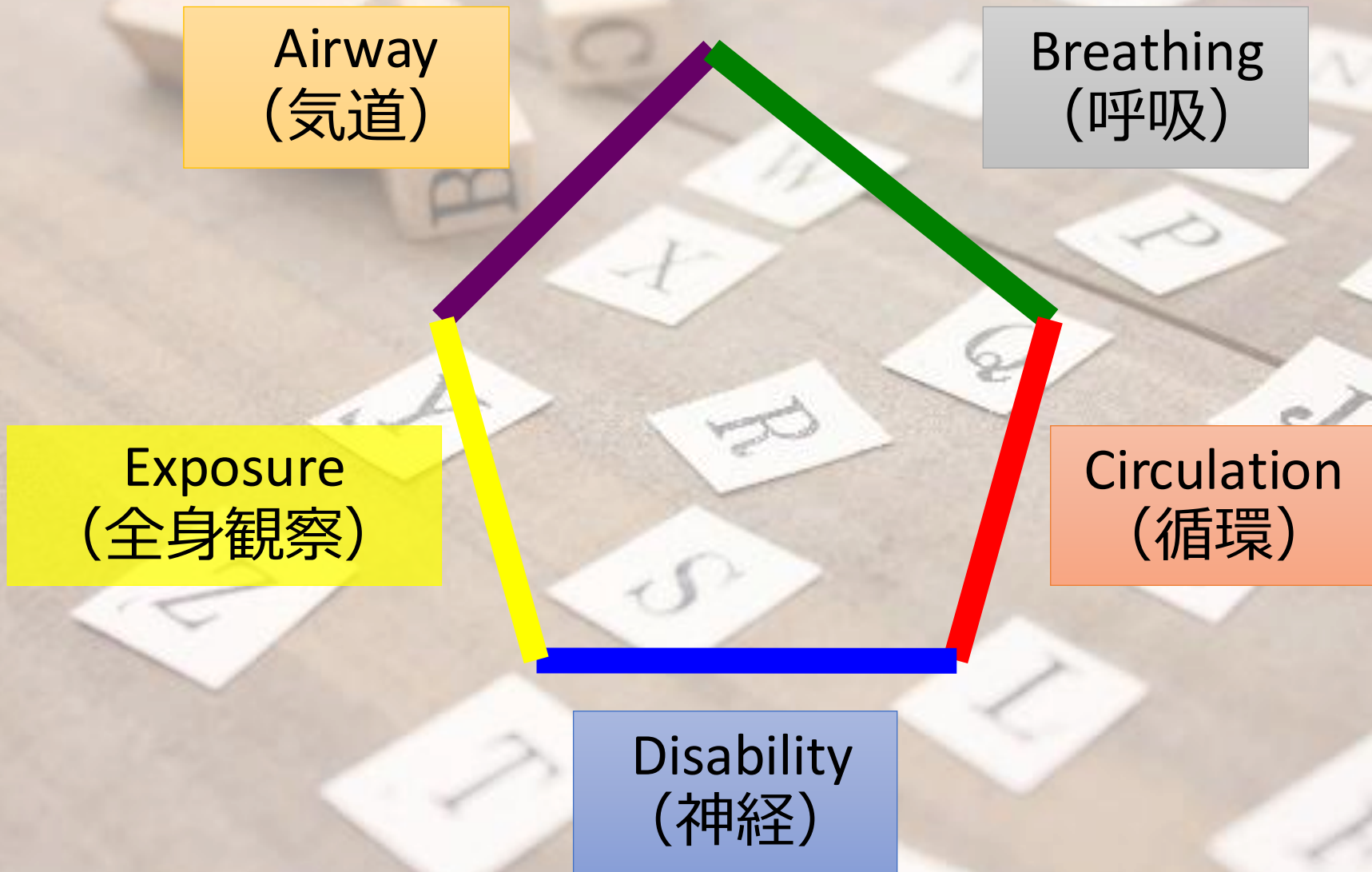
Airway
(気道)

Breathing
(呼吸)

Exposure
(全身観察)

Circulation
(循環)

Disability
(神経)



どこが？



どれくらい悪い？

	タイプ	重症度
呼吸障害	上気道閉塞 下気道閉塞 肺組織（実質病変） 呼吸調節の障害	呼吸窮迫 呼吸不全
循環障害	循環血液量減少性ショック 血液分布異常性ショック 心原性ショック 閉塞性ショック	代償性ショック 低血圧性ショック

生命を脅かす徴候を見逃すな！

A:気道

- 気道閉塞

B:呼吸

- 無呼吸
- 呼吸仕事量↑
- 徐呼吸

C:循環

- 脈拍触知不能
- 循環不良
- 低血圧
- 徐脈

D:神経

- 無反応
- 意識低下

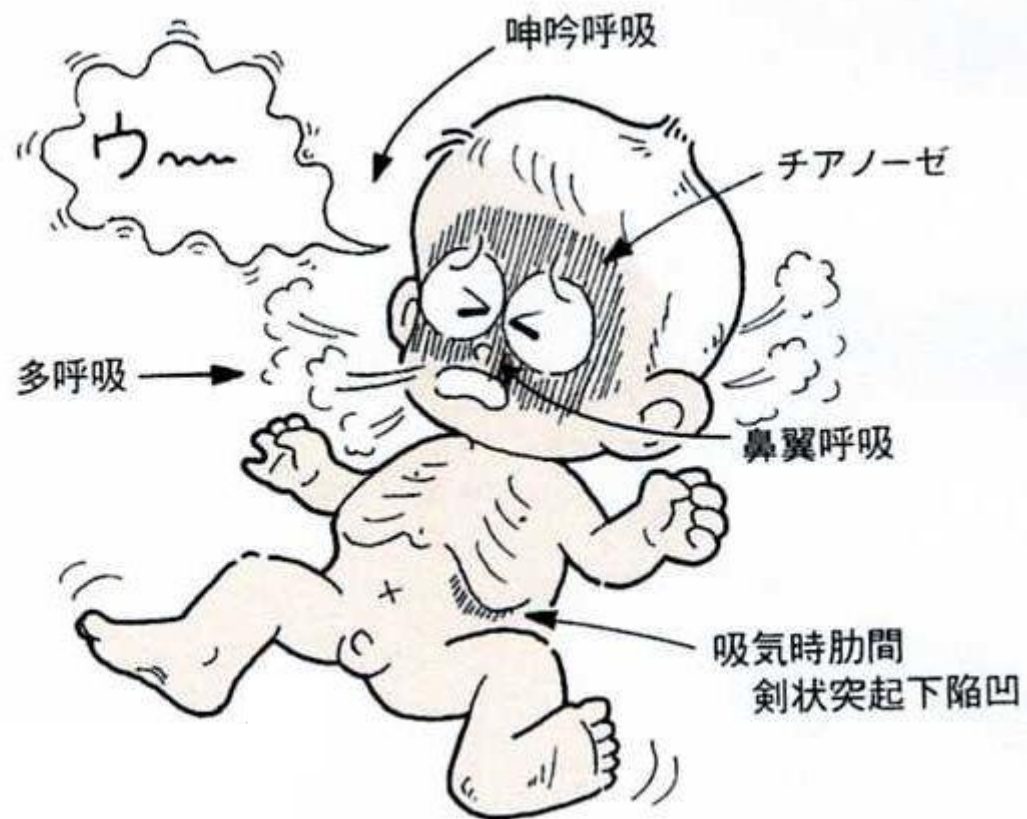
E:全身観察

- 著しい低体温
- 重大な出血
- 出血 / 紫斑
- 腹部膨満

A black and white photograph showing the silhouettes of a child and an adult from behind, looking out a large window. The child, on the left, is leaning their arms on the window sill. The adult, on the right, is holding a smartphone up to take a picture. Outside the window, the nose and cockpit windows of a large airplane are visible. The scene is brightly lit, creating a high-contrast silhouette effect.

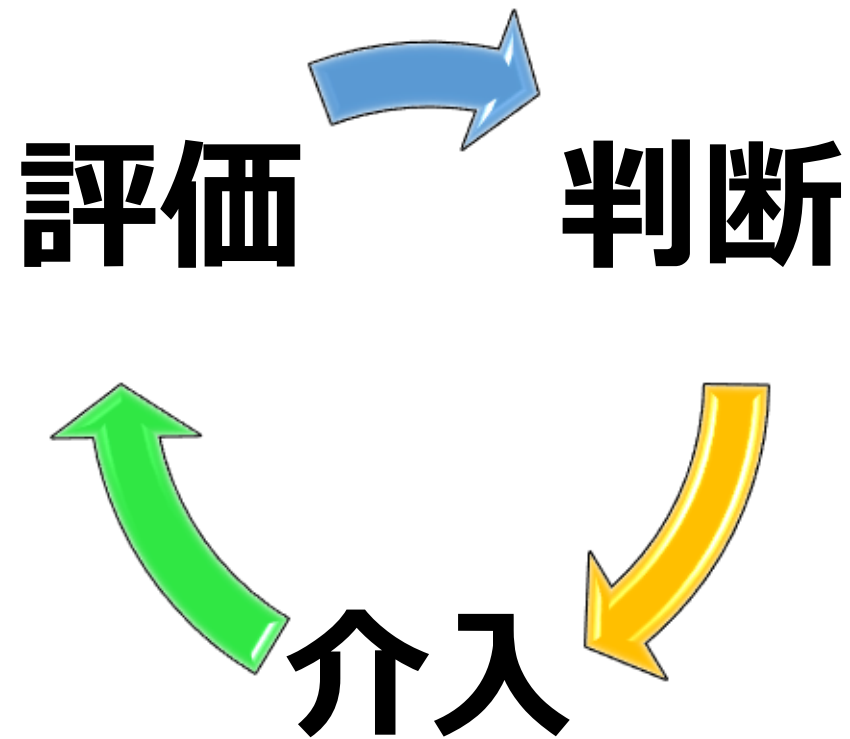
こどもは小さな大人ではない !?

“Children” are not “small adults” !?



Tripod position





この過程のどの段階であっても、生命を脅かす問題を認めたら直ちに救命処置を開始する。

Take home message ②

- 「死んじやいそうかどうか」をまず判断
 - 心停止に至る経路は 3 パターン

- どのような手順で診察したら良いですか？
 - ABCDE アプローチ
 - 生命を脅かす徴候を見逃すな！

- こどもは小さな大人ではない？
 - こどもの呼吸窮迫・代償性ショックの所見は？

- 「判断」したらどう行動しますか？
 - BSL で勉強しましょう

session 3

小児の事故と事故予防



心停止の予防



早期認識と通報



一次救命処置
(心肺蘇生と AED)



二次救命処置と
心拍再開後の集中治療

■ LINE

- 成人の「心停止の原因」で多いものはなんですか？
- 「心停止の予防」するためには、どんな対策が考えられますか？

■ LINE

□ 小児の「心停止の原因」で多いものはなんですか？

	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
0歳	先天奇形等	呼吸障害等	乳幼児突然死 症候群	出血性傷害等	
1～4	先天奇形等			心疾患	インフルエンザ
5～9	悪性新生物		先天奇形等	インフルエンザ	その他の腫瘍
10～14	自殺	悪性新生物		先天奇形等	心疾患
15～19	自殺		悪性新生物	心疾患	先天奇形等

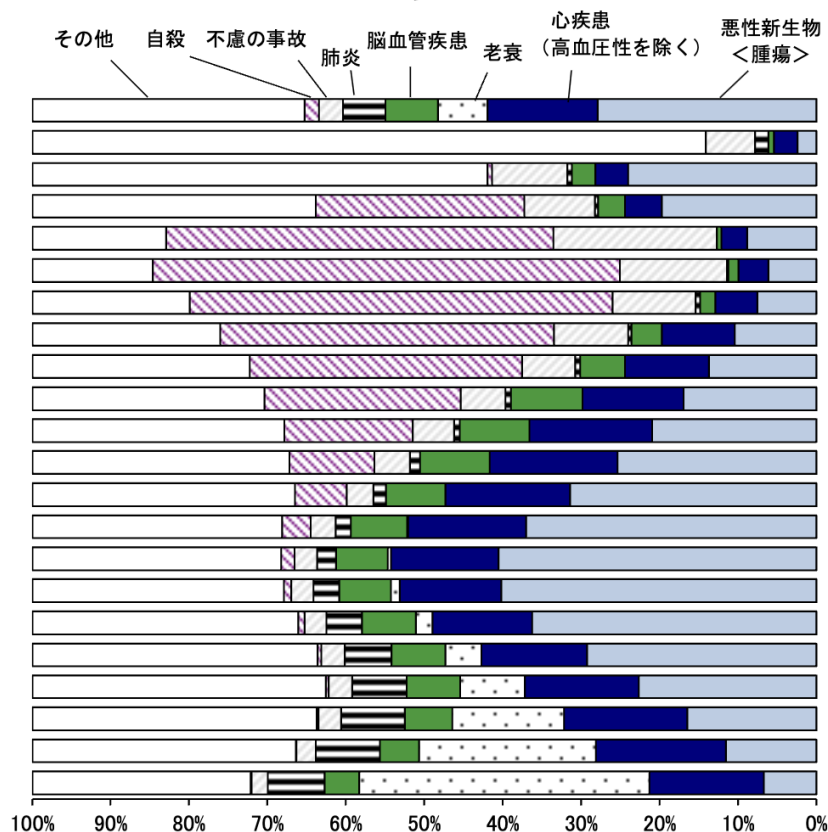


	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位
0歳	先天奇形等	呼吸障害等	乳幼児突然死 症候群	出血性傷害等	不慮の事故
1～4	先天奇形等	悪性新生物 不慮の事故		心疾患	インフルエンザ
5～9	悪性新生物	不慮の事故	先天奇形等	インフルエンザ	その他の腫瘍
10～14	自殺	悪性新生物	不慮の事故	先天奇形等	心疾患
15～19	自殺	不慮の事故	悪性新生物	心疾患	先天奇形等

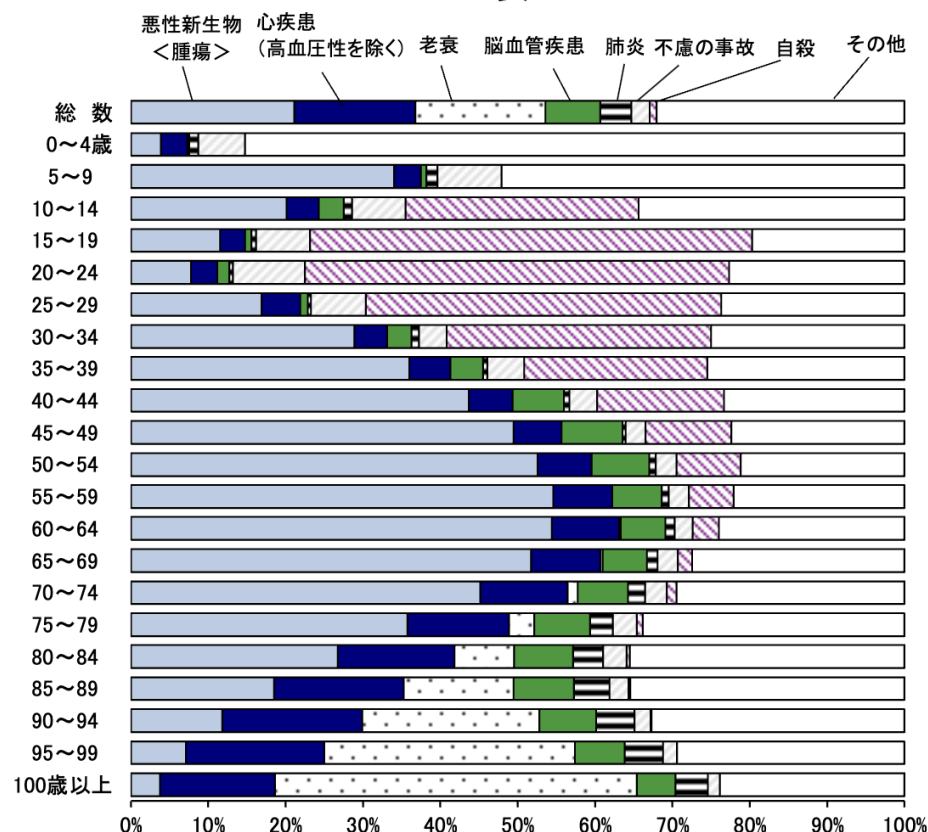


年齢階級別主な死因の構成割合(令和4年)

男



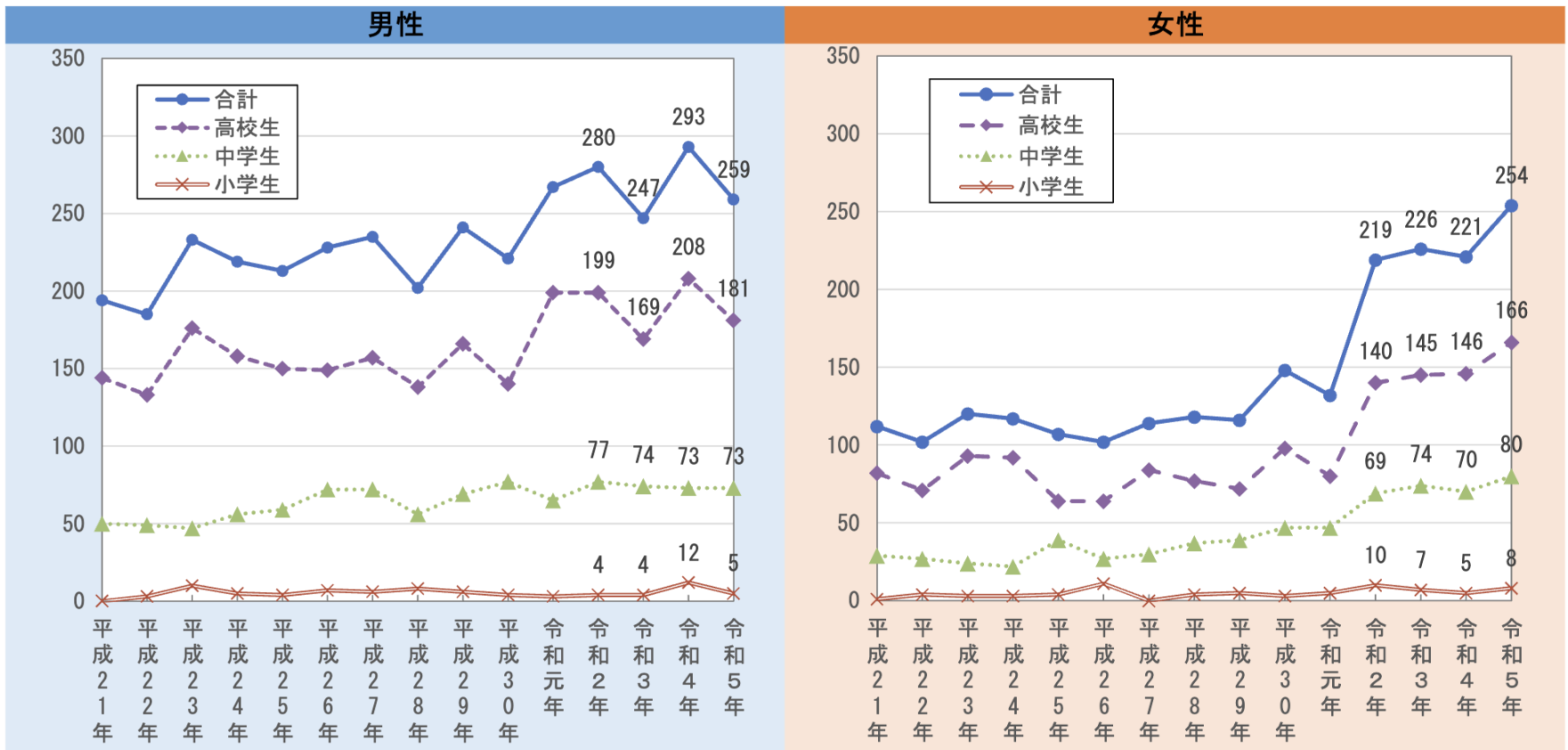
女



図表 1-12 小中高生の自殺者数の年次推移（性別）

○男性は、中学生が前年と同数となり、小学生（7人減）及び高校生（27人減）は減少した。

○女性は、小学生（3人増）、中学生（10人増）及び高校生（20人増）のいずれも増加した。



資料：警察庁自殺統計原票データより厚生労働省作成



■ LINE

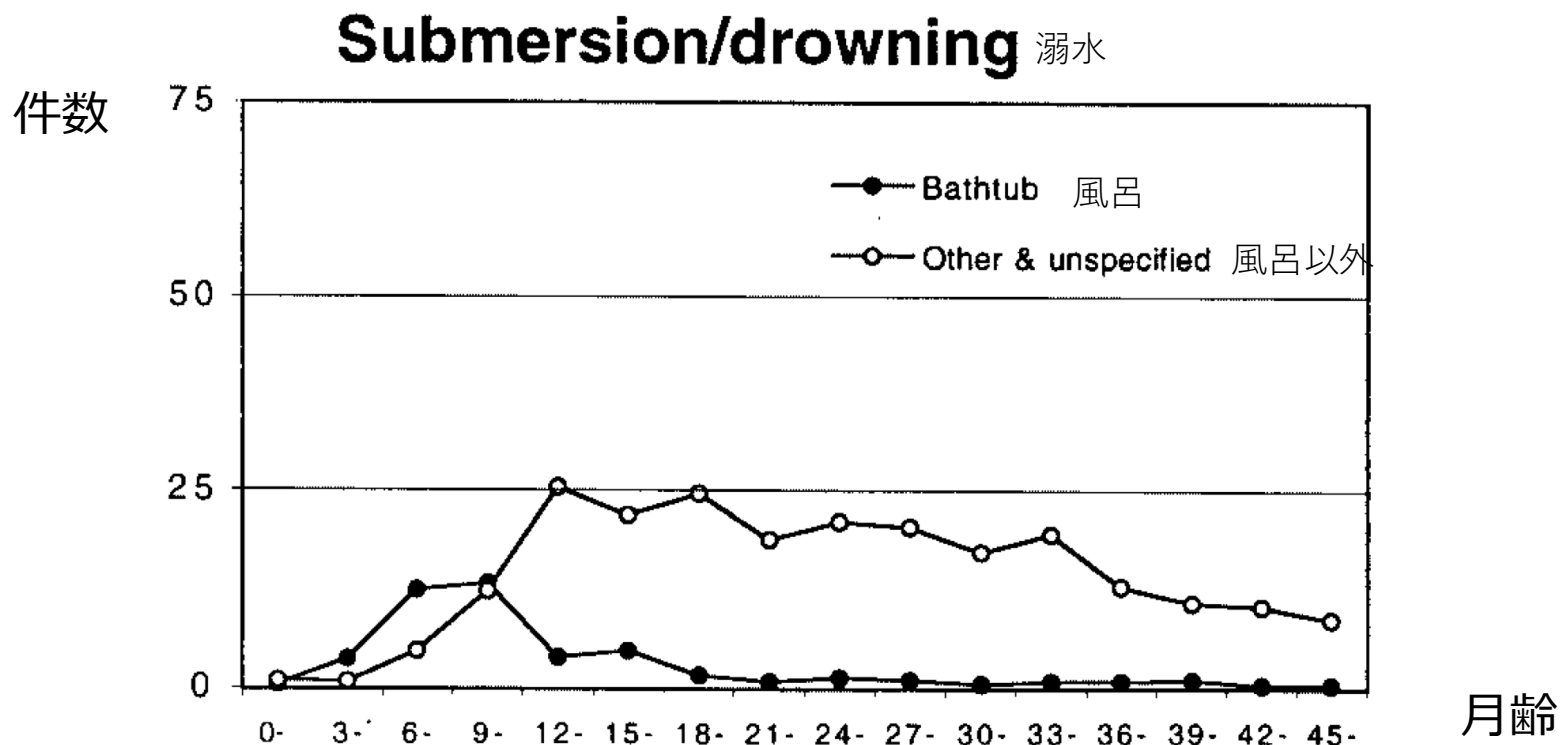
- 子どもと接していて「ヒヤッ」とした経験を教えてください

■ LINE

- こどもの「不慮の事故」は予防できるのでしょうか？
- できるとするなら、どのような対策が有効でしょうか？

■ グラフを見て、以下をLINE に書き込んで下さい。

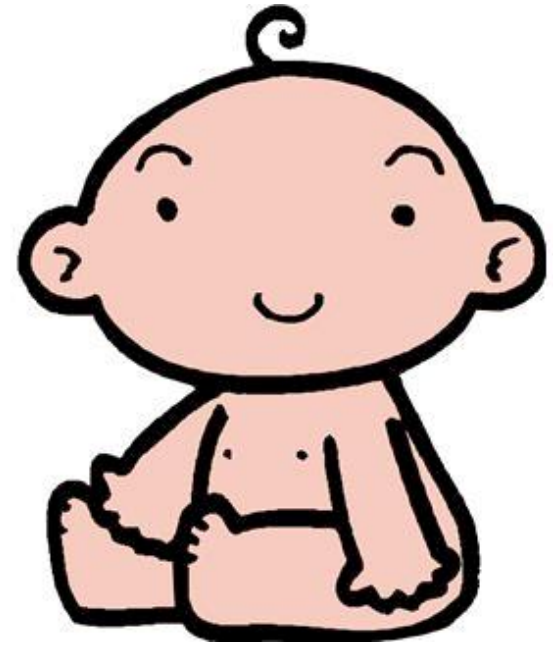
- ① 風呂と風呂以外でピークが違う原因は？
- ② 溺水による事故を予防することは可能ですか？



**Accident
or
Injury ?**



事故は「不注意のため」？



東京都の調査では子どもの事故の
約 9 割は保護者の近くで
約 6 割は親の目の前で

安全ネグレクト??



こどもの事故は
予測可能か？



精神・社会性発達

運動発達

出生

4か月

首のすわり

6か月

7か月

おすわり

9か月

はいはい

人見知り



〈精神・社会性発達〉

〈運動発達〉

1歳

ひとり歩き

1歳6か月

上手に歩く

2歳

その場跳び

3歳

片足立ち
丸を描く

これ以外の主な運動
発達についてはp.64
の表で覚えてください。



パパ、
コッス

意味のある
単語を話す



ママアッチ

2語文を
話す



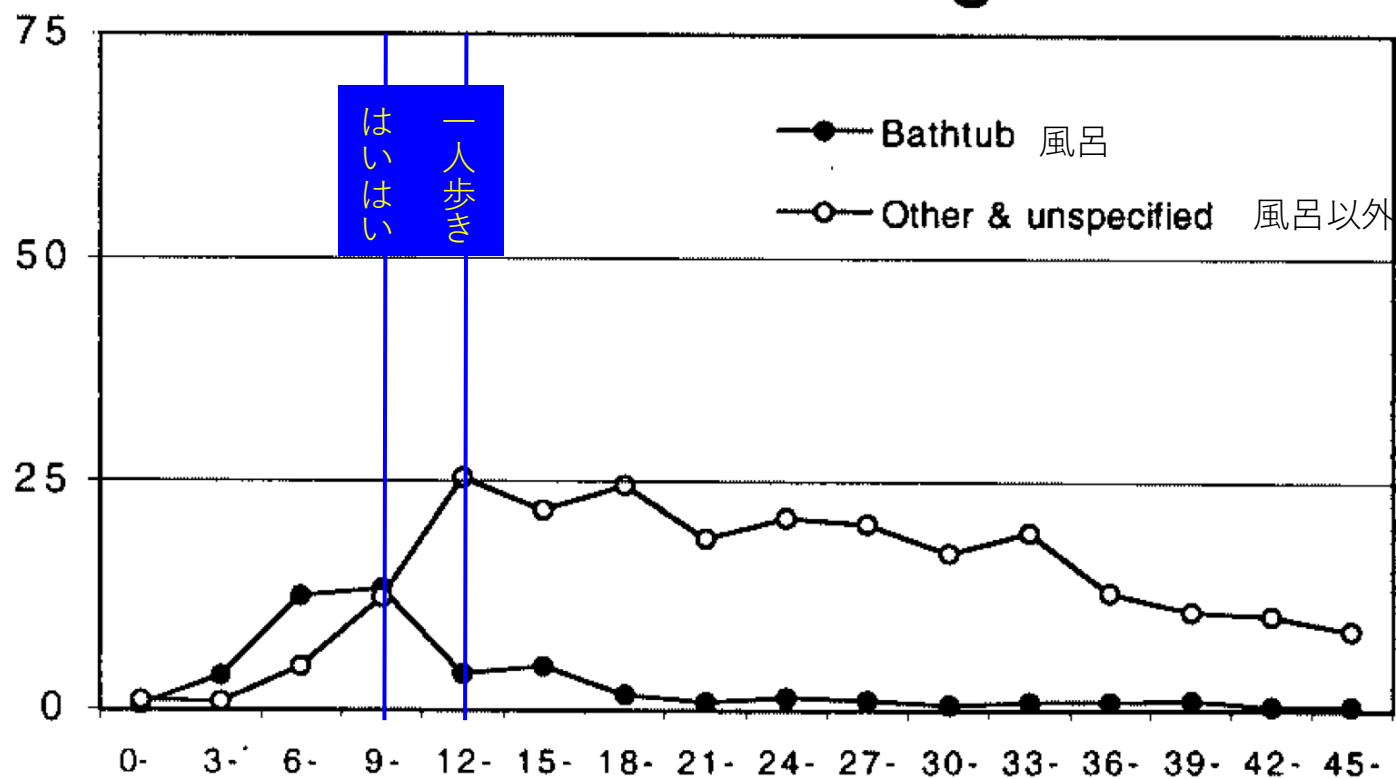
〇山△子
しゃんしゃい(3才)
です。

自分の姓名
を覚える



月・年齢	起きやすい事故	事故の主な原因
新生児	周囲の不注意によるもの	☆誤って上から物を落とす ☆上の子が抱き上げてけがをさせたり、物を食べさせる
1～6ヶ月	転落 やけど 誤飲・中毒 窒息	☆ベッドなどから落ちる ☆ストーブにさわる ☆誤飲で多い物（たばこ、医薬品、化粧品、洗剤など） ☆コイン、豆などの誤飲
7～12ヶ月	転落・転倒 やけど 溺水 誤飲・中毒 車中のけが	☆扉、階段、ベッド、歩行器 ☆アイロン、魔法瓶やポットのお湯 ☆浴槽、洗濯機に落ちる（残し湯をしない） ☆引き出しの中の薬、化粧品、コイン、豆、灰皿のたばこ ☆座席からの転落（ベビー用シートベルトで防止）
1～4歳	誤飲（中毒） 転落・転倒 やけど 溺水 交通事故	☆原因の範囲が広がる。あらゆる物が原因となる ☆階段、ベランダ（踏み台になる物を置かない） ☆熱い鍋に触れる。テーブルクロスを引いて湯をこぼす。 ☆熱いシャワーのいたずら ☆浴槽に落ちる。水遊び。 ☆飛び出し事故（手をつないで歩くこと）

Submersion/drowning 溺水

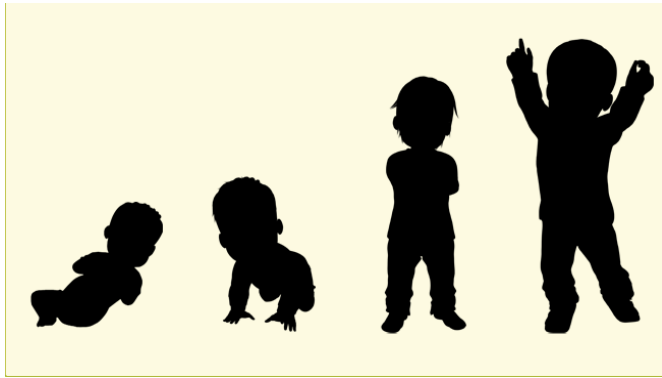


■ LINE

□ 溺水による事故を予防するための効果的な指導は？

➤ どのような指導を？

➤ いつ行う？



成長発達段階に応じて
発生しやすい事故の特徴と対策

保護者が実行可能で、かつ
科学的に有効とされている予防策



保護者がその予防策を実行しようとする
意識・行動変容

- **重症度が高い傷害・後遺症を残す確率が高い傷害**
- **発生頻度が高い傷害・増加している傷害**
- **具体的な解決方法がある傷害**

Take home message ③

■ 事故予防はなぜ必要か？

- 不慮の事故は小児の死因の上位
- 救命の連鎖の一つ目の鎖は「予防」

■ 事故は予測できる

- accident と injury の違い
- 発達年齢と起こしやすい事故の特徴を知る

■ 事故は予防できる

- 科学的かつ有効な対策
- 優先順位
- 行動変容を起こせるかが重要

session 4

子ども虐待

■ LINE に書き込んで下さい

- 診断は？
- 聴取すべき病歴は？

- ✓ 2ヶ月男児
- ✓ 受診 3 日前よりミルクを与えると嘔吐
- ✓ 受診前日 20 時のミルクが最後
- ✓ 以後、傾眠傾向

Physical abuse

Hitting, beating, shaking



Sexual abuse

Sexual contact or exposure to sexual acts or materials



Emotional or psychological abuse

Threatening, insulting, ridiculing, confining

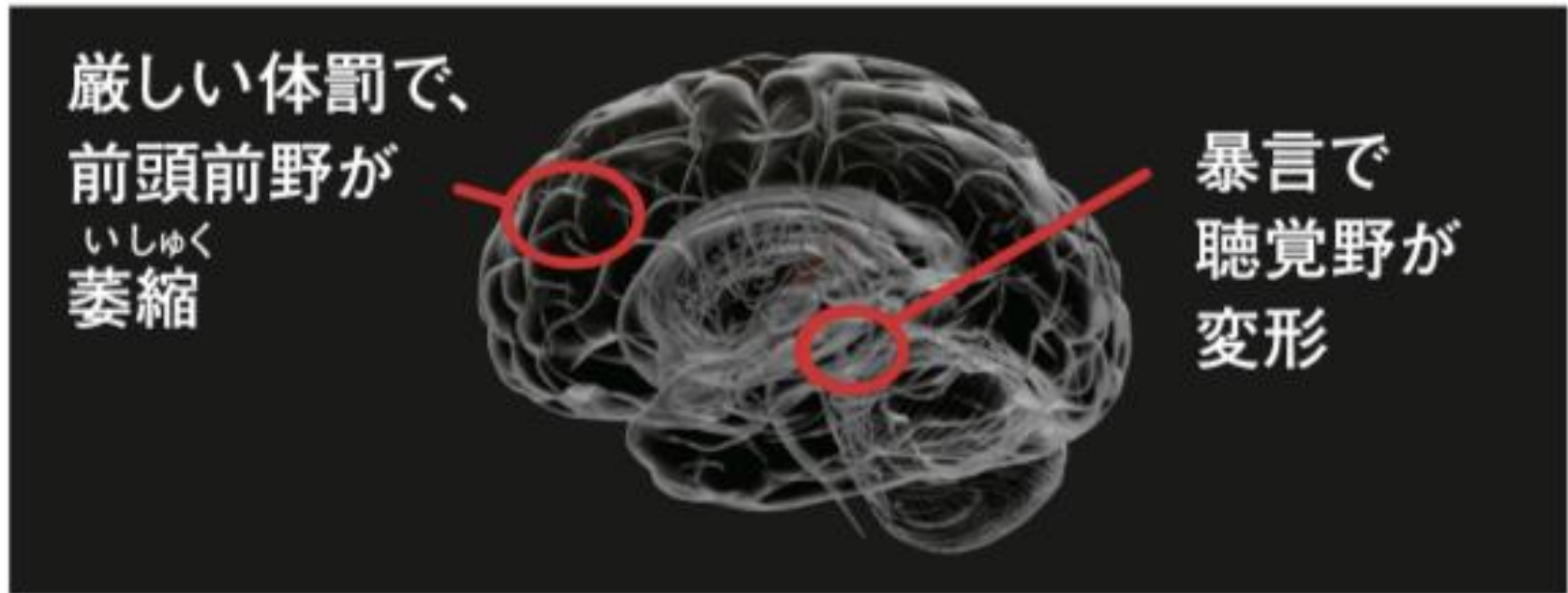


Neglect

Failing, despite having the means, to provide medical care, education, shelter or other essentials for a child's healthy development



●子ども時代の辛い体験により傷つく脳

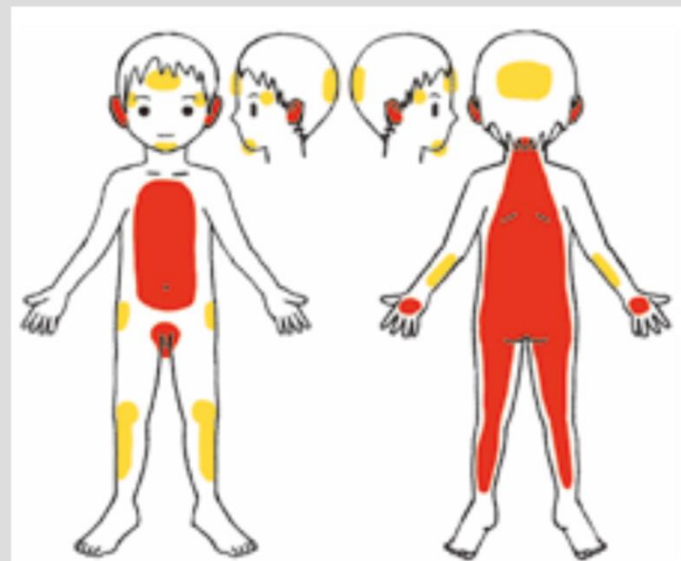


提供：福井大学 友田明美教授

事故予防は何故大切か？

項 目		虐待の可能性が高い	
皮膚損傷	挫 傷	多発性 新旧混在 不自然な分布 感染合併	手形・物の形
	熱 傷		辺縁明瞭で深い
頭部損傷	頭蓋内出血	硬膜下血腫、新旧血腫の併存	
	頭蓋骨骨折	多発性、両側性、骨折線離開 頭頂部陥没	
骨 折	部 位	骨幹端骨折、肋骨・棘突起骨折 胸骨骨折、肩甲骨骨折	
	形 態	らせん状骨折、鉛管骨折	
	年 齢	2歳未満	
その他		CPA-OA 治療奏功しない慢性頭痛・腹痛等	

挫傷・熱傷の存在部位



■ 虐待の可能性が高い ■ 虐待の可能性は低い

* 被服部位、手背、足底、大腿内側に存在した場合も虐待を考慮

Care delay
受療行動の遅れ

損傷が生じてから受診までの時間軸に不自然な所がないか？

History
問診上の矛盾

語る人により受傷機序等の医学ヒストリーが異なっていないか？
一貫性はあるか？ 現症と合致しているか？

Injury of past
損傷の既往

短時間で繰り返してケガで受診している。
カルテが各科別の医療機関は特に要注意。

Lack of Nursing
ネグレクトによる事故・発育障害

何が・いつ・どこで・どのように起きたか、を語れるか？
誰と一緒にいたか？定期受診は？ 検診は？

Development
発達段階との矛盾

『はいはいをしない子に、挫傷や骨折はおこりえない』
● およその目安：寝返り5ヶ月、ハイハイ9ヶ月、始歩13ヶ月

Attitude
養育者・子どもの態度

養育者の、子どもや医療スタッフへの反応や、
子どもの、養育者に対する反応に気になる点はないか？

Behavior
子どもの行動特性

緊張度がきわめて高い、攻撃的な言動が多い、
過度になれなれしい、落ち着きが全くない、性化行動 等

Unexplainable
ケガの説明がない・出来ない

ケガの説明がない場合、虐待/ネグレクトの両面を考慮、
話の出来る年齢の子どもが "分からない" という場合、要注意。

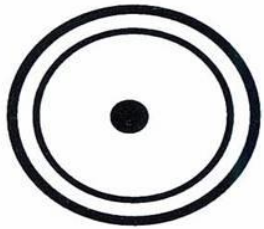
Sibling
きょうだいが加害したとの訴え

重度・複数個所のケガを、幼小児が加えることは極めて稀
幼いきょうだいがいる場合、言い訳として最も汎用される。

Environment
環境上のリスクの存在

家族リスク：社会的孤立、経済的要因、複雑家庭等
子どものリスク：望まぬ出生、育てにくい子ども

電熱器



電球



コテ



シガレットライター



アイロン



ナイフ



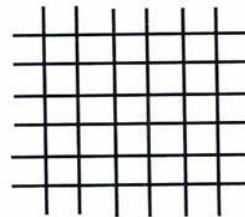
たばこ



フォーク



焼きあみ



熱湯

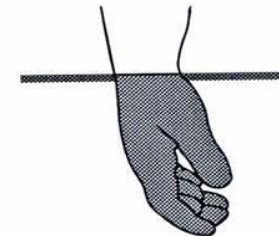


Figure 3.8. Hot objects that may brand a child.

Common hot objects that may leave identifiable shapes and patterns (Johnson, 1990).
Used with permission.

Munchausen Syndrome by proxy



愛の鞭^{むち}ゼロ作戦

子どもを健やかに育むために

子育ての悩みがあるときは

[189]

児童相談所全国共通ダイヤル



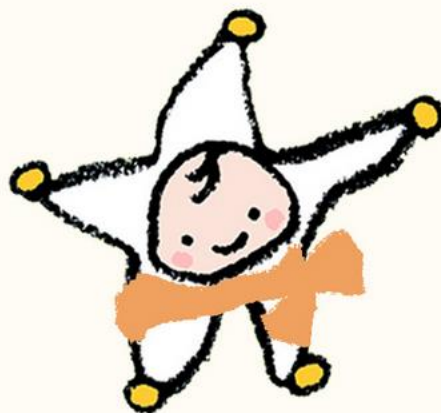
POINT
5

子どもの気持ちと
行動を 分けて考え、
育ちを応援



POINT
4

親自身がSOSを
出そう



子育てに
体罰や暴言を使わない

POINT
1



POINT
2



子どもが親に恐怖を持つと
SOSを伝えられない

POINT
3

爆発寸前の
イライラを
クールダウン



Take Home Message ④

■ 説明の付かない外傷は虐待を考える

- 年齢に応じて起こしやすい事故と虐待の違い
- 病歴聴取は「矛盾」を探す

■ 内因性疾患であっても虐待は否定できない

- 必ず鑑別疾患のリストに「虐待」を入れておく

■ 親も虐待の「被害者」とであると認識する

- 虐待のない社会をどう作るか？という発想を

session 5

advocacy

■ LINE

□ こどもの立場になって考えるとはどういうことですか？

- 普段どんなときに意識しますか？
- どんなことに気をつけたらいいですか？

症例 1, 3 歳 男児

公園で遊んでいて滑り台で転倒、頭頂部に
1.5 cm 程度の挫創を認め、縫合処置をしようとしている。

児は泣き叫び、両親にしがみついている

- ① 本人には説明をしますか？
- ② それは何故ですか？
- ③ 説明をする場合、どのように説明しますか？
- ④ 説明をしない場合、何歳から説明しますか？



1. 人として大切にされ、自分らしく生きる権利

2. 子どもにとって一番よいこと

(子どもの最善の利益) を考えてもらう権利

3. 安心・安全な環境で生活する権利

4. 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利

5. 必要なことを教えてもらい、

自分の気持ち・希望・意見を伝える権利

6. 希望どおりにならなかったときに

理由を説明してもらう権利

7. 差別されず、こころやからだを

傷つけられない権利

8. 自分のことを勝手にだれかに言われたい権利

9. 病気のときも遊んだり勉強したりする権利

10. 訓練を受けたスタッフから治療とケアを

受ける権利

11. 今だけではなく将来も続けて医療やケアを

受ける権利

プレパレーションとデストラクション

第1段階：病院に来る前の事前説明

第2段階：入院・処置のオリエンテーション

第3段階：プレパレーション、真実に基づく説明

第4段階：処置中の気を紛らわせる遊びの介入

第5段階：処置後・退院後の遊び



図21 お母さんに処置台と後ろ向きになるように座ってもらい、ひざの上に子どもを抱っこして子どもの腕を脇にはさんで固定してもらい、点滴や注射の最中おもちゃなどで遊んでいてもらうとよいでしょう。



図22 点滴や注射の最中、お母さんのひざの上に抱っこしてもらい、針を刺しているところがみえないように絵本で隠しながら、読んでもらうと気を紛らわすことができます。介助者は、絵のように関節の両側を固定しましょう。



図24 レインボメーカー。上下にするとカラフルなビーズがキラキラと下に落ちていき、ジャラジャラとにぎやかな音がするので、子どもが興味を示し続けます。



図23 お母さんのひざの上に抱っこしてもらい、人形や音や光るおもちゃなどで遊んでもらうと気を紛らわすことができます。



図25 子どもによっては、じっと見ていたい子どももいます。そのときは、このようにお母さんに抱っこしてもらいましょう。

症例2, 6ヶ月 男児

- 隣の部屋で寝ていたところ、母が30分ほど目を離し、部屋に様子を見に戻ったところぐったりしているところを発見。
- 顔色が悪いことに気づいて救急車を呼んだ。
- 救急隊により、心肺蘇生をしながら搬送、病院で心拍が戻り（心臓が動き出し）集中治療室に入室し加療をした。
- 2日後、脳の機能は破滅的で、いわゆる「植物状態」と医師から説明された。
- 人工呼吸器があれば「生命は維持される」という。

■ 方針について考えてみてください

- 自分が親（家族）だったらどうしますか？
- 自分が主治医だったらどうしますか？

重篤な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いのガイドライン

(登録：2012.04.12)

(改訂：2024.07.21)

2012年に「重篤な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いのガイドライン」(以下、ガイドライン)を制定してから10年以上が経過しました。この間、重篤な病や重度の障害を持つ子どもをめぐる医療はさらに進展し、社会の在り方も変容しました。これらの変化を受け、このたび、ガイドラインを更新いたしました。本学会員、パブリックコメント、家族会等の意見を参考にガイドラインを改訂し、Q&A集を新たに作成いたしました。

本ガイドラインが、目の前の子どもにとってより善い医療・ケアの方針を見出すための個別の熟慮、そして子ども・保護者・医療者の協働の道標となることを願います。そして、それらの議論の積み重ねの先に、年齢や能力に関わらず、すべての子どもたちが等しく尊ばれ、慈しまれ、守られながら、それぞれが持てるいのちを生きる道が社会のなかに切り開かれていくことを期待します。

 [重篤な疾患を持つ子どもの医療をめぐる話し合いのガイドライン](#)



公益社団法人日本小児科学会倫理委員会

本ガイドラインの基本姿勢

1. 子どもの権利利益を守り、子どもの最善の利益に適う医療・ケアの方針を検討する話し合いのプロセスを支えることを目的とする。
2. 小児医療の現場では、治療方針の決定にあたり、子ども・保護者と関係する多くの医療者が、子どもの生命を尊重し、子どもの最善の利益について真摯に話し合い、パートナーシップを確立していくプロセスが最も重視されるべきである。
 - 治療方針について話し合う際、特に方針決定の根拠については、まずは医学的な事実に基づいて治療の妥当性を検討するステップを基盤とする。
 - その上で、子ども・保護者・医療者は、それぞれの価値観や思いを共有し、互いに尊重し支え合う。
3. 子どもの終末期の具体的な定義・対象疾患、また生命維持に必要な治療の差し控えや中止の基準を一律に定めるものではない。

生命維持治療の差し控えや中止の検討

10. 生命維持治療の差し控えや中止は、子どもの生命に不可逆的な結果をもたらす可能性が高いため、以下の事項に則り、特に慎重に検討し、話し合う。

→生命維持治療の差し控えや中止について検討する話し合いに当たり、上述の1-9のことが実施・配慮されているか確認する。

- i. 治療を継続することが子どもの最善の利益に適わないと考えられる場合には、生命維持治療の差し控えや中止を検討することができる。
- ii. 検討に際し、関係する医療者と保護者は、正確な医学的情報を共有し、子どもの最善の利益を考え、話し合いを繰り返し、方針を決定する。
- iii. 子どもの治療に関わるできるだけ多様な立場の関係者が話し合いに参加する場を設定し、当該施設の倫理委員会や倫理コンサルテーションサービスなどにも諮ることが望ましい。
- iv. 生命維持治療の差し控えや中止を決定した場合は、治療の継続が子どもの最善の利益に適わないと判断した根拠を、話し合いの経過・内容とともに診療録に記載する。

臨床倫理の 4 原則

■ 自律尊重

- 自律的な患者の意志決定を尊重せよ
 - ・ 子どもの場合や意識障害の患者の場合は？？

■ 無危害

- do no harm

■ 善行

- do good things

■ 正義

- 利益と負担を公平に配分せよ

医学的適応 (Medical Indications)

善行と無危害の原則

1. 患者の医学的問題は何か？ 病歴は？ 診断は？ 予後は？
2. 急性か、慢性か、重体か、救急か？ 可逆的か？
3. 治療の目標は何か？
4. 治療が成功する確率は？
5. 治療が奏功しない場合の計画は何か？
6. 要約すると、この患者が医学的および看護的ケアからどのくらいの利益を得られるか？ また、どのように害を避けることができるか？

QOL (Quality of Life)

善行と無危害と自律性尊重の原則

1. 治療した場合、あるいはしなかった場合に、通常の生活に復帰できる見込みはどの程度か？
2. 治療が成功した場合、患者にとって身体的、精神的、社会的に失うものは何か？
3. 医療者による患者の QOL 評価に偏見を抱かせる要因はあるか？
4. 患者の現在の状態と予測される将来像は延命が望ましくないと判断されるかもしれない状態か？
5. 治療をやめる計画やその理論的根拠はあるか？
6. 緩和ケアの計画はあるか？

患者の意向 (Patient Preferences)

自律性尊重の原則

1. 患者には精神的判断能力と法的対応能力があるか？ 能力がないという証拠はあるか？
2. 対応能力がある場合、患者は治療への意向についてどう言っているか？
3. 患者は利益とリスクについて知らされ、それを理解し、同意しているか？
4. 対応能力がない場合、適切な代理人は誰か？ その代理人は意思決定に関して適切な基準を用いているか？
5. 患者の事前指示はあるか？
6. 患者は治療に非協力的か、または協力出来ない状態か？ その場合、なぜか？
7. 要約すると、患者の選択権は倫理・法律上最大限に尊重されているか？

周囲の状況 (Contextual Features)

忠実義務と公正の原則

1. 治療に関する決定に影響する家族の要因はあるか？
2. 治療に関する決定に影響する医療者側（医師・看護師）の要因はあるか？
3. 財政的・経済的要因はあるか？
4. 宗教的・文化的要因はあるか？
5. 守秘義務を制限する要因はあるか？
6. 資源配分の問題はあるか？
7. 治療に関する決定に法律はどのように影響するか？
8. 臨床研究や教育は関係しているか？
9. 医療者や施設側で利害対立はあるか？

■ LINE

□ 方針について

- 自分が親（家族）だったらどうしますか？
- 自分が主治医だったらどうしますか？



ADVOCACY

■ LINE

□ 自分が主治医だったらどのように話しますか？

決める



Take Home Message ⑤

■ 「こどもの立場に立つ」とはということか？

- Advocacy とは？ 最善の利益とは何か？

■ 終末期に関するガイドラインについての理解

- 臨床倫理の 4 原則とは？
- 臨床倫理を踏まえた意志決定のプロセス

■ こどもに接するための技術を身につける

- プレパレーションとデストラクション

■ チームで対応する

- チーム内での「医師の責任」とは
- 家族と家庭環境に目を向ける

session 6

災害と小児



“災害” とは何か？

自然災害

人為災害

緊急事態

“災害”

広範囲にわたる
人的、物的、経済的または環境的な
損失および影響

コミュニティまたは社会の機能の深刻な崩壊

Humanitarian Crisis

- ✓ an event or events that threaten the health, safety or wellbeing of a large group of people
- ✓ have devastating physical, psychological and social consequences for children.



THE ALLIANCE
for Child Protection in Humanitarian Action

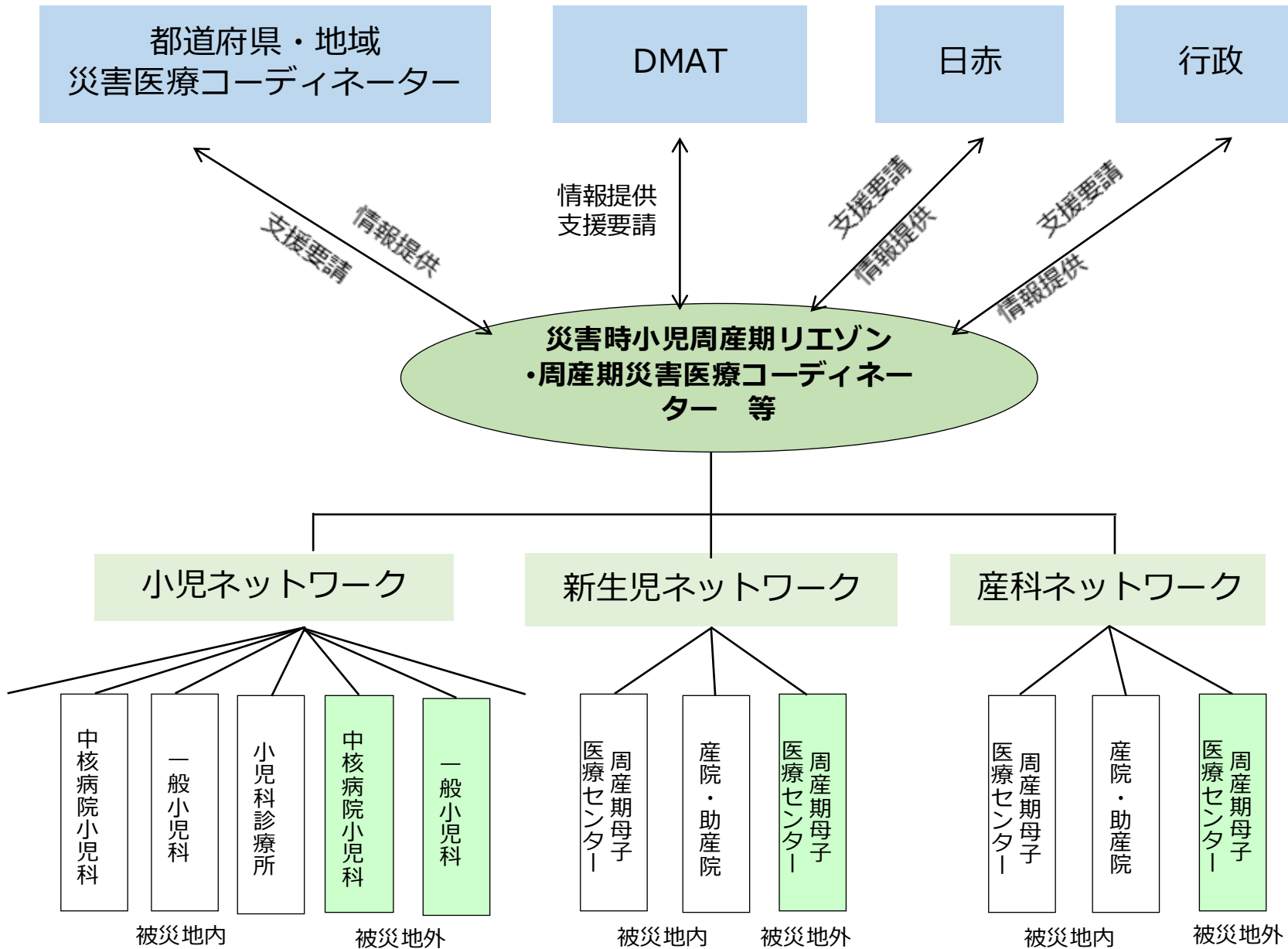
人道行動における 子どもの保護の最低基準 (第2版)



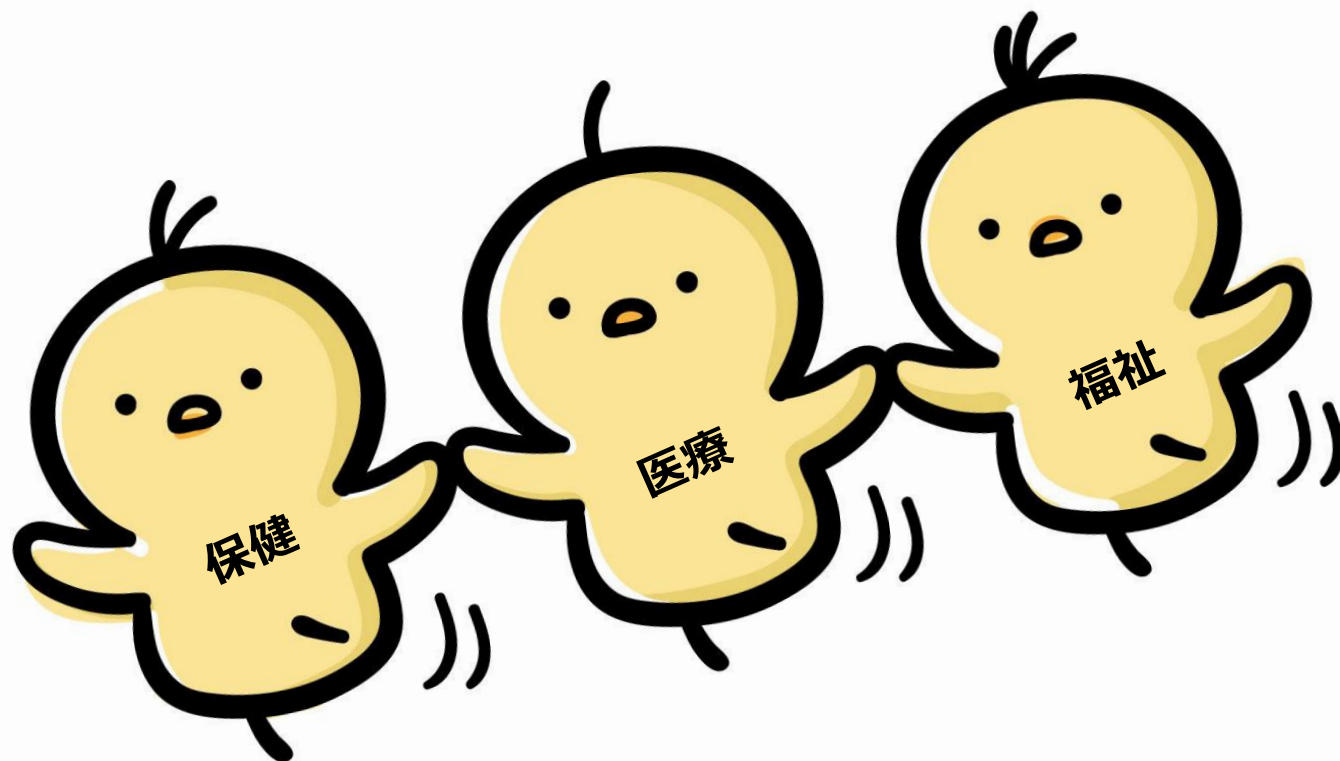
2019 Edition



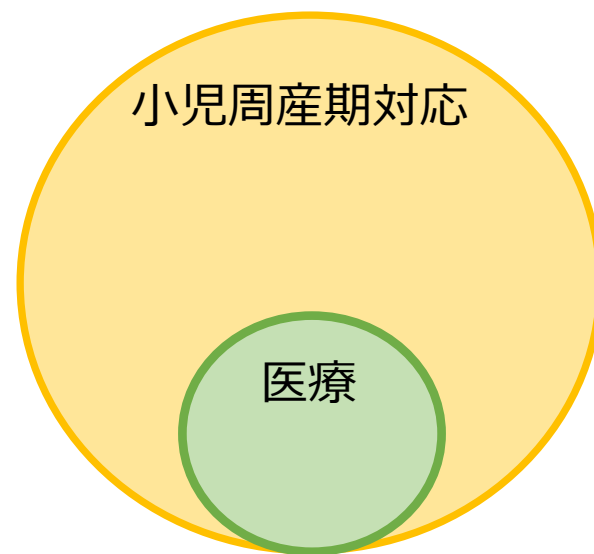
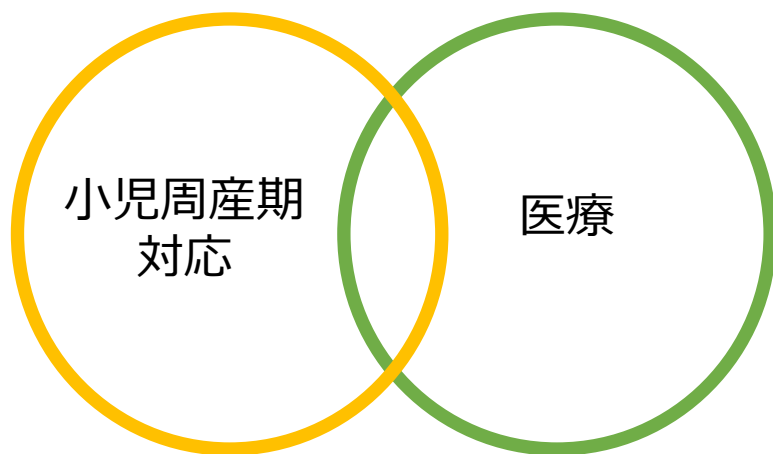
情報窓口としての災害時小児周産期リエゾン



小児周産期医療の特殊性



リエゾンは何をするヒトか？



リエゾンの活動の目的の共有

- そもそも「災害」とは何か？
- 災害が起きると妊婦・子どもたちはどのような状況になるのか？
- 一般論としてどのような対応が必要になるのか？
- 今回の災害の本質は何か？
 - そのような状況特異性を加味すると、一体何が起こるのか？

これらの理解があつてはじめて“戦略”がたち
何をするか（戦術）が決まる



“こどもたち”のために・・・

子どもによくみられる反応・行動

- 手足が動かなくなる、意識消失、各部の痛み、夜尿など
さまざまな身体症状
- 年齢にそぐわない甘え方をしたり、わがままになるなどの赤ちゃん返り
(退行現象)
- 現実にはないことを言い出す
(マジカルシンキング)
- その体験を思わせる遊びや話を繰り返す、いわゆる災害ごっこ
- 突然パニックになる



異常な事態に対する、子どもの通常の反応！

危機的状況下で子どもが示す一般的な反応の例

危機的状況に直面した子どもは、認知発達段階によりさまざまな反応や行動を示すことがあります。これらは、危機的状況下において子どもが示す通常の反応や行動です。認知発達段階には個人差があり、このような反応を示す子どももいれば、全く示さない子もいます。

0~3歳 くらい

何が起きたのか理解できず、ただただ親や養育者にしがみついたり、離れなくなったり、以前は怖がらなかったことを怖がる場合があります。睡眠や食事行動に変化が起きたり、より幼い行動に戻る場合があります。

4~6歳 くらい

親や養育者（主たる愛着対象）の反応を見て、事実を推測します。また、想像力豊かな内面を持っていて、想像的な考え方をすることがよくあるため、**悲惨な出来事を自分のせいだと考え、現実にないことを言い出す**こともあります。

7~12歳 くらい

起きた出来事について同じ言葉や方法で繰り返し話したり、起きた出来事を遊びの中で表現したりする（例えば、震災ごっこなど）ことがあります。これらは、子どもの自然なストレス対処方法の一つでもあるので、遊びを無理に止めずに見守り、良い結果に導けるよう接してください。

13歳以上 くらい

緊急時の深刻さを自分の視点からだけでなく、他者の視点からも理解できるようになります。強い責任感や罪悪感もこの年齢の子どもによくみられる感情で、自滅的な行動をとったり、他者を避けたり、攻撃的な行動が増すこともあります。親や権威に対して反抗的となり、**社会に適合するために、より仲間を頼る**ようになります。

緊急下においてもできる限り、子どもたちの日課や習慣を保ち、子どもたちが安心して遊んだり、学んだり、休息したり、家族や友達と過ごせる機会や場所をつくりましょう。また、ストレスを抱えた子どものケアをする親や養育者を支えることも大切です。親や養育者を尊重し、彼らが自分自身で子どものケアをし、子どもとより良いコミュニケーションが取れるようにサポートをしましょう。

「子どものためのPFA」
もっと詳しく



公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
〒101-0047 東京都千代田区内神田2-8-4 山田ビル4F
TEL: 03-6859-0070 MAIL: japan.pfa@savethechildren.org
制作協力: ソニー株式会社

緊急下の子どものこころのケア



子どものための心理的応急処置

Psychological First Aid for Children (PFA for Children)



子どものための PFAとは

災害などの緊急時に、子どものこころを傷つせず、対応するために。「準備・見る・聴く・つなぐ」の行動原則を基本とした、子どものこころの応急手当てです。

「子どものためのPFA」には次のようなことが含まれます。

- ・ニーズや心配事を確認する。
- ・支援が必要と思われる子どもに寄り添う。
- ・安心して落ち着けるよう手助けする。
- ・子どもの話を聞く。
- ・基本的ニーズ（衣・食・住・基本的な医療など）を満たす。
- ・被災した子どもと親・養育者を、情報や公共サービス、社会的支援につなぐ。
- ・さらなる危害から保護する。
- ・自分で問題に対処できるよう手助けする。

「子どものためのPFA」とは
このようなものではありません。

- ・専門家にしかできないものではありません。
- ・専門家が行うカウンセリングや医療行為ではありません。
- ・何が起ったのかを分析させたり、起きた事を時系列に並べさせることではありません。
- ・子どもの感情や反応を無理に聞き出すことではありません。



Save the Children
セーブ・ザ・チルドレン

準備 Preparation



「見る・聴く・つなぐ」を効果的に行い、
自分の安全を守るための準備

- ・危機的な出来事について調べる。・その場で利用できるサービスや支援を調べる。
- ・安全と治安状況について調べる。

見る Look



1 安全確認を行う

- ・自分の身の安全を確保する。
- ・周囲の危険に注意する。

2 明らかに緊急の対応を必要としている子どもがいなか探す

- ・重傷を負い、緊急医療を必要としている子どもやその家族はいないか？
- ・水や食べ物、衣類の替え、避難場所などを必要としている子どもはいないか？
- ・虐待や暴力などの危険にさらされていると思われる子どもはいないか？

3 深刻なストレスを抱えている子どもがいなか確認する

- ・特別な支援を必要とする子どもはいないか？
- ・普段と様子が違う子どもはいないか？

聴く Listen



1 支援が必要と思われる子どもに寄り添う

- ・優しく穏やかに話しかけ、自己紹介する。
- ・目線が子どもと同じ高さになるように身をかがめたり、しゃがむ。
- ・子どもが話したいときに話せるような安心・安全な環境をつくる。

2 子どものニーズや気がかりなことについて尋ねる

- ・何が必要で、何が心配を確認する。
- ・できることを一緒に考えるなど手助けをし、子どもが自ら問題に対処できるよう支える。

3 子どもの話に耳を傾け、気持ちを支える手助けをする

- ・子どもやその家族に寄り添う。
- ・話すことを無理強いしない。
- ・起きた出来事について子どもやその家族が話したい場合は、耳を傾ける。

つなぐ Link



● 基本的なニーズが満たされ、適切な支援が受けられるようサポートする

- ・安全の確保、衣・食・住・基本的な医療など、生きていく上で必要な基本的ニーズが満たされるよう情報を提供したり、つないだりする。
- ・特に必要としているもの（例えば、アレルギー対応の離乳食など）を把握し、それが入手できる場所へつなげる。

● 自分で問題が対処できるよう手助けをする

- ・危機的状況下の子どものニーズは多様である。
- ・何でもしてあげるのではなく、できるだけ子どもの自助力を促す。

専門的な支援を必要とする子ども

生きていく上で必要な基本的ニーズが満たされ、安全、尊厳、権利が守られ、家族や地域からの支援を受けることで、多くの子どもは専門的な支援を必要とせず、再びもとの状態に自分の力で戻るようになります。

しかし、子どもの中には、長期にわたって強いストレスを抱えていたり、日常生活に支障をきた

● 子どもを、大切な人や社会からの支援につなぐ

- ・子どもが家族や大切な人と離ればなれにならないよう支援する。
- ・例えば、遊びや学びなど、子どもが必要としている特有のニーズを理解し、支援につなげる。

● 情報を提供する

- ・子どもやその家族が必要とする情報を提供する。

【危機に見舞われた人が求める主な情報】

- ・基本的ニーズに関すること
- ・発生した出来事
- ・影響を受けた大切な人たちの状況
- ・自分たちの安全
- ・自分たちの権利
- ・必要な援助や物資を得る方法

すなど、自分だけでは対処できず、さらなる支援を必要とする子どももいます。

その際には、精神保健医療の専門機関や専門家につなげる必要があります。すぐに専門家につなげるのが難しい場合は、保健師、養護教諭、教員など、地域の人たちからさらなるサポートが受けられるようつなぐことが大切です。

Take Home Message ⑥

- 「災害」とは何か？
- 「災害」が起きると、こどもたちに何が起きるか？
 - Humanitarian crisis
- 「災害」後に衣達によく現れる反応・行動
 - magic thinking
 - ごっこ遊び
- 具体的な対応方法としての PFA

session 6

closing

テストについて

- 症例を提示し、適切な判断・指導などを選択していただきます
- Take Home Message に挙げた項目を中心として関連する NOTE を含め、復習して下さい
 - NOTE のリストは別途提示します
- 到達目標は「講義の目標」を参考にして下さい

振り返り



振り返りの内容を共有しよう

- アンケート内の振り返りで記載した項目を近くの人と共有してみよう。

成長と発達コース

事故と救急

名古屋市立大学病院 救急科

今井一徳

事後配付資料

事務連絡

■ LINEのオープンチャットは3/28を目処に閉鎖します。

□ 保存をしたい方は各自ダウンロードをして下さい

■ google form

□ 匿名化してアップロードしてもらいます

□ 同級生がどのような振り返りをしているかを知ることとはとても意味があると思いますので、一度読んでみることを強く推奨します。

NOTE

■また一緒に走ろう

□https://note.com/pec_picu

- 目次
 - https://note.com/pec_picu/n/nba785badb4c8

Session 1

- (1) 小児救急総 ① 総論
 - 小児科 × 救急

Session 2 ①

■Video: けいれん

□ https://www.youtube.com/watch?time_continue=487&v=xAmtU1-YOcI&feature=emb_logo

■(1) 小児救急総 ① 総論

□ こどもは何故死ぬのか?

■(1) 小児救急総 ② PALS

□ 心停止が切迫していることに気づく

□ “なんか変”は小児科医の“匠の技”か

Session 2 ②

- (2) 呼吸② PALS
 - 全部
- (3) 循環① PALS
 - 全部
- (4) 神経①PALS
 - こどもの意識レベルの評価法
- (1) 小児救急総 ②PALS
 - こどもは小さな大人ではない!

Session 2 ③

■ Video: こどもの呼吸の見方

□ <https://www.youtube.com/watch?v=n4rYJCukg8>

Session 3, 4

■(1) 小児救急総 ③ 事故予防・虐待

□ 全部

■ 参考

□効果的な対策とは何か考えてみてください。

- <https://www.youtube.com/watch?v=4luPqykJTsc>
- <https://www.youtube.com/watch?v=y1yNmDV1dK0>
- <https://www.youtube.com/watch?v=27Ej-ZUWvUU>
- https://www.youtube.com/watch?v=Eo_kx_ZyRik

Session 5

- (1) 小児救急総 ④ 臨床倫理
 - 全部

Session 6 災害医療

■ (13) 災害医療 ② 災害医療体制

- 災害時病院はどう行動するか？|
- 病院の連絡体制を確立する
- 災害時医療体制と災害時小児周産期リエゾン

■ (17) コラム ② 活動報告

- 大規模地震時医療搬送訓練 ①-③
- 災害時小児周産期リエゾン養成研修①-②

テストの参考として

- (15) 症例検 ① Virtual 症例帖1
 - ①-③ でひとつのケースです